

UNDP VIỆT NAM
VĂN KIẾN ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH 2005/1

**NGOÀI XĐGN:
KHUÔN KHỔ HỆ THỐNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUỐC GIA HỢP NHẤT
Ở VIỆT NAM**

Hà Nội, tháng 3/2005

Bản quyền © 2005 Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Giấy phép xuất bản số: 230/XB-QLXB do Cục Xuất bản,
Bộ văn hóa-Thông tin cấp ngày 19 tháng 4 năm 2005

Ảnh bìa: Lại Diễm Đàm
Thiết kế mỹ thuật: Đặng Hữu Cự/UNDP Việt Nam

In tại Việt Nam

VĂN KIẾN ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH UNDP VIỆT NAM
2005/1

NGOÀI XĐGN:
KHUÔN KHỔ HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI QUỐC GIA
HỢP NHẤT Ở VIỆT NAM

Patricia Justino*

Tháng 3-2005

* Ban Nghiên cứu về Nghèo tại Sussex, Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Tổng hợp Sussex, Arts Building E, Falmer, Brighton, BN1 9SN. Email: a.p.v.justino@sussex.ac.uk

Lời nói đầu

Việt Nam đã bước vào thời kỳ thay đổi về kinh tế và xã hội chưa từng có từ trước tới nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đã tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đáng kể mức sống cho hàng triệu người dân Việt Nam. Quá trình phát triển kinh tế cũng làm chuyển đổi bản chất rủi ro kinh tế đối với nhiều hộ gia đình. Việt Nam phần lớn vẫn là một xã hội nông nghiệp và rủi ro kinh tế chủ yếu liên quan đến mất mùa, thiên tai và giá cả hàng hoá. Những nhân tố này chắc chắn vẫn là những nhân tố quan trọng trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, sẽ có các dạng rủi ro khác phát sinh ngày càng nhiều, nhất là những rủi ro liên quan đến vị thế của người dân trên thị trường lao động.

Giúp các hộ gia đình và cá nhân quản lý được những dạng rủi ro kinh tế mới là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà Chính phủ Việt Nam hiện đang phải đối mặt. Trong những năm tới, các nhà hoạch định chính sách sẽ quyết định hình thức và qui mô của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Có thể dễ dàng thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa việc cải thiện hệ thống bảo hiểm xã hội và việc thực hiện các nguyên tắc và tinh thần của Tuyên bố Thiên niên kỷ trong đó có các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Bảo hiểm xã hội là một bộ phận cấu thành trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo và đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản của toàn dân. Các chương trình bảo hiểm xã hội hợp nhất có thiết kế tốt và thực hiện hiệu quả cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình đẳng xã hội và tinh thần đoàn kết.

Văn kiện này là đóng góp đầu tiên cho một loạt các Văn kiện Đối thoại Chính sách mới của UNDP Việt Nam. Mục tiêu của các văn kiện này là nhằm khuyến khích thảo luận về các vấn đề nảy sinh và tìm hiểu các phương án chính sách trên quan điểm so sánh quốc tế.

Chúng tôi xin cảm ơn bà Patricia Justino đã nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình hiện nay ở Việt Nam và về sự hiểu biết sâu sắc của bà dựa trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu, Vụ trưởng Vụ Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, nhận xét chi tiết và sửa các bản thảo trước đây.

UNDP chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DfID) cho văn kiện thảo luận chính sách này trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Chiến lược DfID-UNDP.

Jordan Ryan

Đại diện Thường trú UNDP

Mục lục

Lời nói đầu	ii
Mục lục bảng	iv
Mục lục Hình	iv
Mục lục Khung	iv
Lời cảm ơn	v
Các từ viết tắt	vi
Tóm tắt tổng quan	vii
1. Phần mở đầu	8
2. Tại sao là một khuôn khổ bảo hiểm xã hội hợp nhất?	3
2.1. Thay đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam	3
2.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam	4
2.3. Các khó khăn và thách thức tiềm ẩn	9
2.4. Cơ hội tiềm ẩn nhờ các chính sách bảo hiểm xã hội	11
3. Khái niệm bảo hiểm xã hội ở Việt Nam	13
3.1. Sự khác nhau giữa các chính sách bảo hiểm xã hội và giảm nghèo	13
3.2. Đối tượng các chính sách bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển	14
3.3. Vai trò của nhà nước	14
3.4. Bản chất lũy tiến của các chính sách bảo hiểm xã hội	15
4. Đề xuất về thiết kế và thực hiện chương trình ở Việt Nam	17
4.1. Thành phần hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất ở Việt Nam	17
4.3. Khả năng tài chính	25
4.4. Năng lực thể chế	27
4.5. Vấn đề thời gian	28
5. Kết luận và kiến nghị	29
PHỤ LỤC: Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Quốc gia hợp nhất ở Việt Nam	31
Tài liệu tham khảo	33

Mục lục bảng

Bảng 1: Các chỉ số nghèo ở Việt Nam

Bảng 2: Bất bình đẳng ở Việt Nam

Bảng 3: Chi tiêu công cho các lĩnh vực xã hội ở Việt Nam

Bảng 4: Mức trợ cấp trung bình của bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội (1998)

Bảng 5: Kết quả về sức khỏe của một số nhóm ngũ phân vị

Bảng 6: Chi tiêu cá nhân cho y tế năm 2002 theo nhóm ngũ phân vị tiêu dùng

Bảng 7: Chi ngân sách ước tính cho trợ cấp toàn dân

Mục lục Hình

Hình 1: Thu nhập phúc lợi xã hội theo đầu người ở Việt Nam tính theo nhóm ngũ phân vị chi tiêu

Mục lục Khung

Khung 1: Chi phí chương trình xét trên quan điểm quốc tế

Khung 2: Hai mô hình trợ cấp ở khu vực chính thức: Trung Quốc và Chile

Khung 3: Bảo hiểm xã hội cho khu vực không kê khai ở Nam Ấn Độ

Khung 4: Dân ngoại tỉnh ở thành thị Trung Quốc

Khung 5: Bảo hiểm y tế ở Trung Quốc

Khung 6: Trợ cấp không yêu cầu đóng góp ở Nam Phi

Lời cảm ơn

Tôi xin cảm ơn ông Jonathan Pincus, Chuyên viên Kinh tế Quốc gia Cao cấp, UNDP Việt Nam đã thu xếp các cuộc phỏng vấn và các tài liệu quan trọng, đã nhận xét và gợi ý cho văn kiện này và sự hiểu khách trong thời gian tôi làm việc tại Việt Nam; Tiến sĩ Saurabh Sinha, là điều phối viên và tác giả chính của công trình đánh giá xuất sắc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo và Chương trình 135, đã đóng góp những ý kiến nhận xét thảo luận quý giá; Tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu, Vụ trưởng Vụ Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo trợ xã hội tại Việt Nam và đã đóng góp ý kiến nhận xét cho các bản thảo trước của văn kiện này; và bà Nguyễn Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã dành thời gian thảo luận các vấn đề chủ chốt của dự án và tạo điều kiện cho tôi tìm hiểu nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau. Tôi cũng xin cảm ơn ông Nguyễn Tiến Phong đã chia sẻ hiểu biết của mình về xã hội và kinh tế Việt Nam và đã nhận xét các bản thảo trước của văn kiện này. Tác giả văn kiện này xin chịu trách nhiệm về tất cả các sai sót. Dù đây là một Văn kiện Đối thoại Chính sách của UNDP, song các quan điểm trình bày ở đây chỉ là quan điểm của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh các quan điểm của Liên Hợp Quốc hoặc các nước thành viên của Liên Hợp Quốc.

Các từ viết tắt

BHYTVN	Bảo hiểm Y tế Việt Nam
Bộ LĐ-TBXH	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
BYT	Bộ Y tế
CTMTQG	Chương trình mục tiêu quốc gia
DfID	Bộ Phát triển Quốc tế Anh
DNNN	Doanh nghiệp Nhà nước
ĐTMSHGĐVN	Điều tra Mức sống Hộ Gia đình Việt Nam
ĐTMSVN	Điều tra Mức sống Dân cư
FDI	Đầu tư trực tiếp của nước Ngoài
GTZ	Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức
ILO	Tổ chức Lao động Quốc tế
TCTK	Tổng Cục Thống kê
UBDTMN	Ủy ban Dân tộc Miền Núi
UNDP	Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNICEF	Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
XĐGN	Xoá đói giảm nghèo
WTO	Tổ chức Thương mại Thế giới

Tóm tắt tổng quan

Văn kiện này phân tích các vấn đề bảo hiểm xã hội chủ yếu ở Việt Nam và đề xuất một khuôn khổ về mặt khái niệm nhằm xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất. Mục tiêu chính là xem xét làm thế nào có thể phát triển hoặc hợp nhất các hợp phần cụ thể trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm Nghèo (CTMTQG) hiện nay cùng với các chương trình bảo hiểm xã hội hiện có cho đối tượng khu vực chính thức thành một hệ thống quốc gia hợp nhất. Văn kiện này thảo luận các điều kiện tiên quyết chủ yếu về thể chế, tài chính và kinh tế vĩ mô để xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Các phân tích chủ yếu dựa trên kinh nghiệm quốc tế và với mục tiêu không phải xây dựng một kế hoạch chương trình mà nhằm tìm hiểu các vấn đề chủ yếu cần nghiên cứu thêm. Tài liệu này tập trung vào bốn câu hỏi chính:

1. Liệu Việt Nam có cần một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất không, và nếu cần thì khi nào?
2. Có những thuận lợi và bất lợi gì khi hợp nhất các cơ chế và chính sách bảo trợ xã hội hiện có, kể cả các cơ chế và chính sách thuộc CTMTQG về giảm nghèo, thành một hệ thống quốc gia, và những thay đổi này trên thực tế sẽ đòi hỏi những gì?
3. Việt Nam có thể học hỏi những gì từ kinh nghiệm ở các nước công nghiệp và các nước đang phát triển khác về việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất?
4. Có những thuận lợi và bất lợi gì xét về khả năng tài chính, tính thực tiễn, năng lực thể chế và hiệu quả khi giới hạn phạm vi đối tượng so với áp dụng toàn dân?

Do cơ cấu kinh tế ở các nước đang phát triển, chẳng hạn như thu nhập thấp, tầm quan trọng tương đối của lao động tự do và các thị trường vốn vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nên nếu chuyển ngay sang thiết lập các hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện sẽ không thực tế. Do có những hạn chế về mặt tài chính và thể chế nên cũng giới hạn khả năng lựa chọn của các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, điều kiện ở các nước đang phát triển không loại bỏ khả năng chính phủ hành động để tăng bảo hiểm xã hội cho những nhóm dân cư và hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất. Trên thế giới đã có nhiều ví dụ về các biện pháp can thiệp thực tế khả thi về mặt tài chính và thể chế thực hiện ở các nước như Việt Nam. Thách thức trong thời kỳ trung hạn là làm sao xác lập rõ ràng các ưu tiên, phối hợp tốt hơn giữa các thành phần hiện có trong hệ thống bảo hiểm xã hội và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

1. Phần mở đầu

Chính phủ Việt Nam đã chính thức bắt đầu Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) về Xóa đói Giảm nghèo (XDGN) vào tháng 7-1998. Hiện nay trong CTMTQG có một loạt các thành phần trong đó có đầu tư vào hạ tầng cơ sở ở các cộng đồng dân cư nghèo, trợ cấp tín dụng, miễn giảm học phí, miễn giảm phí khám chữa bệnh, các chương trình tái định cư hoặc “định canh định cư” và khuyến nông. Có một chương trình riêng trên qui mô lớn để phát triển cơ sở hạ tầng ở một số các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) và đây cũng là một trong những nỗ lực giảm nghèo của chính phủ, dù về mặt quản lý hành chính chương trình này hiện tách riêng khỏi CTMTQG. Chính phủ đã bắt đầu thiết kế lại CTMTQG cho giai đoạn kế hoạch sắp tới (2006-2010).

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã hỗ trợ một cách nhất quán các nỗ lực của chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện CTMTQG và các chương trình khác trong chiến lược quốc gia để giảm ngay lập tức các dạng nghèo cùng cực về cả khả năng phát sinh và mức độ. UNDP đã hỗ trợ cho chính phủ trong công tác đánh giá CTMTQG và Chương trình 135. Quá trình đánh giá đã được thực hiện phối hợp cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) và các cơ quan ban ngành khác, và kết quả được công bố vào tháng 11-2004 (UNDP 2004).

Trong đánh giá của UNDP-Bộ LĐ-TBXH đã nêu lên một số vấn đề liên quan đến giai đoạn mới của CTMTQG và Chương trình 135, trong đó có những vấn đề mang tính chất kỹ thuật và hiện đang được các nhóm công tác kỹ thuật tham gia thiết kế giai đoạn sau giải quyết. Các vấn đề khác liên quan đến các câu hỏi chính sách mang tính chất căn bản hơn. Trong số đó có vấn đề về mối quan hệ giữa CTMTQG và khái niệm rộng về bảo hiểm xã hội, và câu hỏi quan trọng liệu các thành phần trong mạng lưới an sinh xã hội của chương trình hiện nay về lâu dài có thể kết hợp được với các chương trình bảo hiểm xã hội hiện có, dù hạn chế, để hình thành nên cơ sở hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hay không.

Mục đích của Văn kiện Đối thoại Chính sách này của UNDP là xem xét CTMTQG và các cơ chế bảo hiểm xã hội khác ở Việt Nam trên quan điểm quốc tế và tìm hiểu khả năng liệu các chương trình này có thể hình thành nên cơ sở cho một hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất trên toàn quốc hay không. Văn kiện này mang tính chất khái niệm và mục đích chính là đưa ra một khuôn khổ thảo luận và đề xuất các phương hướng nghiên cứu trong tương lai về việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất ở Việt Nam. Tài liệu này tập trung vào bốn câu hỏi chính:

- i. Liệu Việt Nam có cần một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất không, và nếu cần thì khi nào?
- ii. Có những thuận lợi và bất lợi gì khi hợp nhất các cơ chế và chính sách bảo trợ xã hội hiện có, kể cả các cơ chế và chính sách thuộc CTMTQG về giảm nghèo, thành một hệ thống quốc gia, và những thay đổi này trên thực tế sẽ đòi hỏi những gì?
- iii. Việt Nam có thể học hỏi những gì từ kinh nghiệm ở các nước công nghiệp và các nước đang phát triển khác về việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất?
- iv. Có những thuận lợi và bất lợi gì xét về khả năng tài chính, tính thực tiễn, năng lực thể chế và hiệu quả khi giới hạn phạm vi đối tượng so với áp dụng toàn dân?

Văn kiện này bắt đầu bằng phần thảo luận về sự cần thiết phải có một khuôn khổ bảo hiểm xã hội hợp nhất ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều thay đổi về kinh tế và xã hội ở trong nước trong thập kỷ qua và đánh giá các vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện một khuôn khổ như vậy (Phần 2). Trong phần này sẽ tập trung vào hai vấn đề cụ thể là khả năng đứng vững về mặt tài chính khi mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội cho các đối tượng lao động hiện chưa được bảo hiểm trong các chương trình hiện nay và các hạn chế đối với việc mở rộng các hệ thống có đóng góp xét về các cơ cấu thị trường lao động hiện nay ở Việt Nam.

Mong muốn phát triển các chương trình hiện có thành một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia xuất phát những nhận xét sau:

- i. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế kết hợp với các cấu trúc gia đình thay đổi do xã hội Việt Nam có tính chất đô thị hoá và công nghiệp hoá hơn đã tạo ra những dạng rủi ro kinh tế mới đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết có tổ chức hơn. Chẳng hạn như tuổi già và ốm đau giờ đây là những nguyên nhân chính gây nghèo ở Việt Nam;

- ii. Các chương trình bảo hiểm xã hội làm giảm rủi ro kinh tế-xã hội và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương không bị giảm mức sống. Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, các chương trình bảo hiểm xã hội cũng kích thích tăng trưởng kinh tế trong dài hạn bằng cách mở rộng các thị trường nội bộ và thúc đẩy sự tích lũy vốn nhân lực và duy trì sự gắn kết xã hội và ổn định chính trị;

Trong Phần 3 sẽ phân tích khái niệm bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Chúng tôi giải quyết bốn vấn đề chính liên quan đến việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội khả thi về mặt xã hội và tài chính trong một nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam, đó là:

- i. Khái niệm về bảo hiểm xã hội và giảm nghèo không đồng nghĩa với nhau;
- ii. Khả năng tiếp cận các chương trình bảo hiểm xã hội của người lao động ở cả những khu vực kê khai và không kê khai;¹
- iii. Cơ sở lập luận về sự tham gia của nhà nước hoặc vào quá trình thực hiện hoặc vào quá trình qui định các chính sách bảo hiểm xã hội hoặc cả hai; và
- iv. Bản chất lũy tiến của các chương trình bảo hiểm xã hội.

Trong Phần 4 thảo luận những thách thức chủ yếu trong quá trình xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia ở Việt Nam. Trong mục này tập trung vào năm vấn đề cụ thể như sau:

- **Phạm vi đối tượng chương trình:** Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay không đến được hết thậm chí các đối tượng thụ hưởng theo dự định. Do vậy cần phải xem xét ngay lập tức các cách mở rộng các chương trình hiện nay để đến được với người lao động trong khu vực chính thức từ trước tới nay chưa được bảo hiểm, người lao động trong khu vực không kê khai và lao động tự do, dân ngoại tỉnh ở các thành thị, các dân tộc thiểu số và các nhóm chưa được bảo hiểm;
- i. **Ưu tiên chương trình:** Do hạn chế về ngân sách nên chính phủ phải ưu tiên. Các nhu cầu cấp thiết nhất là bảo hiểm y tế và bảo hiểm tuổi già. Cụ thể chúng tôi xem xét khả năng thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn dân được bổ sung thêm bằng một hệ thống chăm sóc sức khỏe bao cấp và phương án trợ cấp xã hội không yêu cầu đóng góp;
- ii. **Khả năng tài chính:** Chính phủ có thể tăng ngay lập tức qui mô ngân sách xã hội bằng nhiều biện pháp trong đó có sự tham gia nhiều hơn của các công ty nhà nước và tư nhân trong quá trình đóng bảo hiểm chống lại các rủi ro trên thị trường lao động; tập trung các mạng lưới an sinh vào các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể hơn là vào người nghèo nói chung, và tăng chi chuyển khoản từ các tỉnh giàu sang tỉnh nghèo;
- iii. **Năng lực thể chế:** Có ba vấn đề thể chế cần chú ý ngay lập tức, đó là năng lực giám sát của các hệ thống đóng góp hiện có để giảm mức độ trốn đóng góp, các kênh truyền thông và phối hợp giữa ba bộ có liên quan để giảm thiểu trùng lặp; và cải thiện luồng thông tin giữa các hệ thống của chính phủ và giữa các chương trình và các bên hưởng bảo hiểm.
- iv. **Thời điểm:** Chính phủ cần tận dụng các điều kiện kinh tế thuận lợi hiện nay để xây dựng một chiến lược tài chính cho hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất trong tương lai. Mặc dù hiện đã có các dạng tổ chức không chính thức để giúp xã hội giải quyết được các nhu cầu hiện tại, song những tổ chức như vậy vẫn chưa đủ trong tương lai với tốc độ thay đổi về xã hội và kinh tế như hiện nay. Chính phủ cần phải hành động từ bây giờ, khi mà nhiều bộ phận dân cư vẫn tiếp cận với các dạng tổ chức không chính thức, để chuẩn bị đến lúc cần phải có biện pháp giải quyết có tổ chức hơn của nhà nước.

¹ Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “khu vực không kê khai” (unenumerated sector) để nói đến người lao động làm việc trong những ngành không được đăng ký chính thức. Chúng tôi muốn sử dụng thuật ngữ này hơn là khái niệm được sử dụng phổ biến “khu vực không chính thức” (informal sector) vì khái niệm này bao hàm lao động tự do hoặc làm việc trong những công ty rất nhỏ. Tuy nhiên, nhiều lao động trong khu vực được gọi là “không chính thức” này lại là lao động thường xuyên ăn lương và chỉ khác “khu vực chính thức” ở chỗ là khu vực chính thức có đăng ký với các cơ quan hữu quan của nhà nước. Ngoài ra, có nhiều công ty trong khu vực không kê khai cũng lớn hoặc thậm chí còn lớn hơn các công ty trong khu vực “chính thức”. Một điểm quan trọng khác cần nhớ nữa là các thông tin liên quan đến số lao động có làm công ăn lương so với lao động tự do có độ tin cậy rất thấp. Chẳng hạn, theo ước tính trong Điều tra Mức sống Dân cư (ĐTMSVN) năm 1998 thì chỉ có 19% lực lượng lao động làm công ăn lương theo hình thức nào đó. Chỉ bốn năm sau con số này đã tăng lên đến 30% (Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2004).

2. Tại sao là một khuôn khổ bảo hiểm xã hội hợp nhất?

Tốc độ thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đã đưa vấn đề bảo hiểm xã hội lên đầu chương trình chính sách. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, tỷ lệ người lao động làm công ăn lương trong lực lượng lao động tăng, các giao dịch thị trường thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống, chuyển dịch ngành từ nông nghiệp sang các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, và hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành thị, tất cả đều góp phần thay đổi hình thức và mức độ rủi ro kinh tế và xã hội đối với hàng triệu người Việt Nam. Một hệ thống bảo hiểm xã hội có thiết kế tốt có thể góp phần vào quá trình phát triển của quốc gia bằng cách giúp người dân quản lý được những rủi ro này và đồng thời mở rộng và tăng cường chiều sâu của thị trường trong nước, giảm bất bình đẳng và tạo đòn bẩy quản lý vi mô kinh tế mới.

2.1. Thay đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam

Việt Nam được công nhận rộng khắp là một nước đang phát triển thành công nhờ tốc độ tăng trưởng và giảm nghèo nhanh. Những thành tựu này là nhờ hệ thống các cuộc cải cách kinh tế toàn diện bắt đầu vào năm 1986 vẫn được biết đến với tên gọi *đổi mới* (Ngân hàng Thế giới 1999; Viện Quản lý Kinh tế Trung ương 2000; Haughton, Haughton và Nguyễn 2001). Sự khởi đầu *công cuộc đổi mới* đã đánh dấu sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, trong đó có áp dụng các chính sách như xoá bỏ sự kiểm soát về giá cả, trao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp, nới lỏng sự kiểm soát đối với các hoạt động kinh tế tư nhân, giảm hoặc xoá bỏ các rào cản thương mại và mở cửa nền kinh tế Việt Nam cho đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Trong nông nghiệp, các hộ gia đình được giao đất và người nông dân được quyền ra các quyết định quản lý nên tốc độ đầu tư và tăng năng suất đã tăng vọt.

Do có những thay đổi chính sách như vậy nên kể từ năm 1987 tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam đã tăng với tốc độ bình quân hàng năm là 7%. Từ một nước nhập khẩu lúa gạo vào những năm 1980, giờ đây Việt Nam trở thành một nước xuất khẩu lúa gạo lớn và các sản phẩm hàng hoá khác. Việt Nam đã nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường hàng sản xuất quốc tế. Chuẩn mực hiện nay là ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có tỷ lệ tiết kiệm cao và tỷ lệ lạm phát thấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đi liền với tốc độ giảm nghèo mạnh theo như kết quả theo dõi được ở cả nông thôn và thành thị và ở hầu hết các nhóm kinh tế-xã hội. Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống còn 28,9% trong năm 2002 (Bảng 1).

Bảng 1: Các chỉ số nghèo ở Việt Nam

	1993	1998	2002
Tỷ lệ nghèo	58,1	37,4	28,9
Thành thị	25,1	9,2	6,6
Nông thôn	66,4	45,5	35,6
Người Kinh và người Hoa	53,9	31,1	23,1
Dân tộc thiểu số	86,4	75,2	69,3
Vùng núi phía Bắc	81,5	64,2	43,9
Đông Bắc	86,1	62,0	38,4
Tây Bắc	81,0	73,4	68,0
Đồng bằng sông Hồng	62,7	29,3	22,4
Duyên hải Bắc Trung bộ	74,5	48,1	43,9
Duyên hải Nam Trung bộ	47,2	34,5	25,2
Tây Nguyên	70,0	52,4	51,8
Đông Nam bộ	37,0	12,2	10,6
Đồng bằng sông Cửu Long	47,1	36,9	23,4
Nghèo lương thực	24,9	15,0	10,9
Thành thị	7,9	2,5	1,9
Nông thôn	29,1	18,6	13,6
Người Kinh và người Hoa	20,8	10,6	6,5
Dân tộc thiểu số	52,0	41,8	41,5
Vùng núi phía Bắc	42,3	32,4	21,1
Đông Bắc	29,6	17,6	15,4
Tây Bắc	26,2	22,1	46,1
Đồng bằng sông Hồng	24,2	8,5	5,3
Duyên hải Bắc Trung bộ	35,5	19,0	17,5
Duyên hải Nam Trung bộ	22,8	15,9	9,0

Tây Nguyên	32,0	31,5	29,5
Đông Nam bộ	11,7	5,0	3,0
Đồng bằng sông Cửu Long	17,7	11,3	6,5

Nguồn: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004. Tỷ lệ nghèo và khoảng cách nghèo dựa trên ngưỡng nghèo chính thức của TCTK
Chú thích: Tỷ lệ nghèo được tính bằng tỷ lệ phần trăm dân số dưới ngưỡng nghèo.

Nhờ có *đổi mới* nên mới có kết quả phi thường này. *Đổi mới* cũng làm tăng nhu cầu cần có các hệ thống bảo hiểm xã hội hoạt động có kết quả hơn. Việt Nam không chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997 vì đồng tiền của Việt Nam không có khả năng chuyển đổi và do Việt Nam quản lý được tình hình nợ nước ngoài. Song dù sao thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam rõ ràng cũng chậm lại, tốc độ tăng FDI mới giảm, tăng trưởng xuất khẩu thấp hơn và có giai đoạn tốc độ tăng việc làm cũng chậm lại (Ngân hàng Thế giới 2002). Những sự kiện này cho thấy hội nhập kinh tế gắn liền theo nó cả rủi ro cũng như lợi ích và những rủi ro này truyền đến người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương thông qua các thị trường lao động và sản phẩm.

Ngoài ra, trong thời kỳ *đổi mới* Việt Nam cũng thay đổi đáng kể về mặt xã hội trong đó có những thay đổi về cơ cấu độ tuổi và cấu trúc gia đình, dạng thức việc làm và các mối quan hệ lao động, đô thị hoá và sự bất bình đẳng về thu nhập giữa các vùng và ngay trong từng vùng. Những xu hướng này đã làm tăng sức ép đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp giải quyết mang tính tổng thể, hợp nhất và có kết quả hơn đối với các rủi ro kinh tế và xã hội phát sinh.

Bảng 2: Bất bình đẳng ở Việt Nam

	1993	1998	2002
Việt Nam	0,34	0,35	0,37
Thành thị	0,35	0,34	0,35
Nông thôn	0,28	0,27	0,28
Vùng núi phía Bắc	0,25	0,26	0,34
Đồng bằng sông Hồng	0,32	0,32	0,36
Duyên hải Bắc Trung bộ	0,25	0,29	0,30
Duyên hải Nam Trung bộ	0,36	0,33	0,33
Tây Nguyên	0,31	0,31	0,36
Đông Nam bộ	0,36	0,36	0,38
Đồng bằng sông Cửu Long	0,33	0,30	0,30

Nguồn: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004.

Chú thích: Bất bình đẳng tính theo hệ số Gini. Hệ số Gini nằm trong khoảng 0 (bình đẳng tuyệt đối) and 1 (bất bình đẳng tuyệt đối).

Các cơ chế, dự án và chính sách được nhóm thuộc CTMTQG là một nỗ lực phối hợp về phía chính phủ để tấn công vào các hình thức nghèo cùng cực. CTMTQG và các chương trình có liên quan được xây dựng bên cạnh hệ thống bảo hiểm xã hội hiện có làm cho công tác phối hợp càng có nhiều vấn đề hơn cả về mặt quản lý hành chính và về định hướng chính sách. Những vấn đề về phối hợp này có thể trở nên càng rắc rối hơn với tình hình kinh tế-xã hội thay đổi nhanh chóng như đã nói ở trên. Những khoảng cách trong hệ thống an sinh xã hội sẽ trở nên rõ ràng hơn khi ngày càng có nhiều bộ phận dân cư vượt ra khỏi trong các nhóm hiện thuộc diện đối tượng của CTMTQG, hệ thống bảo trợ xã hội hiện có và các dạng không chính thức. Do vậy giờ đây cần phải có các biện pháp để bắt đầu quá trình khắc phục tình trạng phân tán hiện nay và tiến tới một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất.

2.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã thể hiện một cách nhất quán cam kết mạnh mẽ về phát triển xã hội. Chi tiêu của chính phủ cho các dịch vụ xã hội vẫn duy trì ở mức ổn định khoảng 30% kể từ năm 1994. Trong năm 2002, phần chi tiêu xã hội lớn nhất là cho giáo dục, tiếp theo sau đó là trợ cấp, và các khoản cứu trợ xã hội khác như hỗ trợ cho đối tượng anh hùng cách mạng, các chi tiêu xã hội và y tế khác (Bảng 3).

Bảng 3: Chi tiêu công cho các lĩnh vực xã hội ở Việt Nam

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Chi cho xã hội	32,0	33,0	32,3	33,4	33,3	30,2	29,8	31,3	29,7
Giáo dục	7,8	8,6	8,7	10,1	10,2	9,4	9,6	10,1	10,4
Y tế	5,0	4,4	4,4	4,3	4,1	3,7	3,4	2,9	3,0
Lương và trợ cấp xã hội	13,3	13,5	13,0	13,0	11,7	10,6	10,4	11,2	9,3
Các khoản khác	5,8	6,9	6,1	6,1	6,7	6,4	6,4	7,1	7,0

Nguồn: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004. Dựa theo ước tính của Bộ Tài chính.

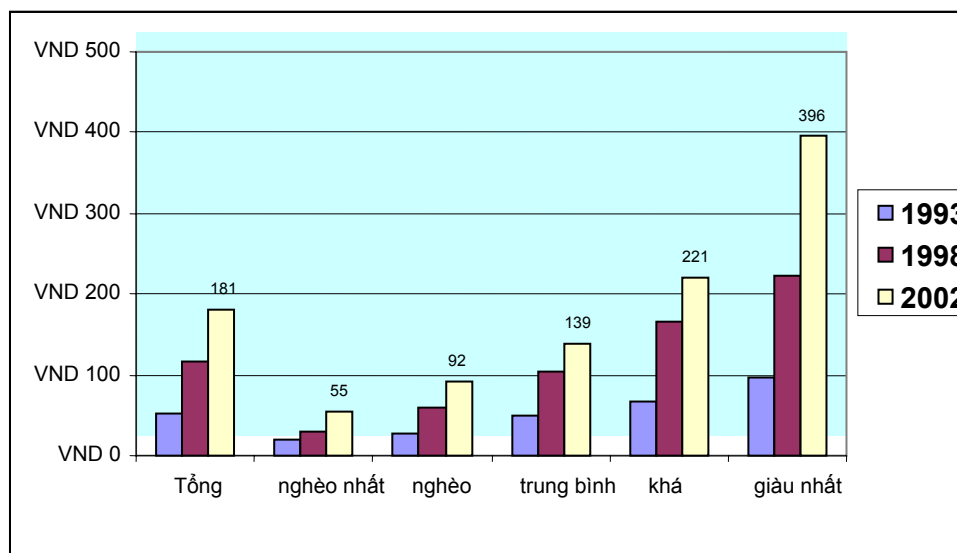
Chú thích: Số liệu được tính bằng tỷ lệ phần trăm trong tổng chi tiêu của Chính phủ.

Trong các hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại có ba yếu tố cơ bản: (i) bảo hiểm xã hội trong đó có bắt buộc và tự nguyện (nói chung là các chương trình có đóng góp) để đối phó với rủi ro gián đoạn nguồn thu nhập bình thường do thất nghiệp, ốm đau, mất sức lao động và thai sản, và để rải đều thu nhập trong toàn bộ cuộc đời của người lao động; (ii) trợ giúp xã hội dựa vào xác minh tiềm lực tài chính nhằm giảm bớt khó khăn và hỗ trợ kinh tế cho các nhóm dễ bị tổn thương thông qua chi chuyển khoản công (bằng tiền mặt và hiện vật); và (iii) chi chuyển khoản cho các nhóm đối tượng để cung cấp nguồn lực bổ sung cho cứu trợ xã hội (chẳng hạn như Phúc lợi Trẻ em ở Anh và *phân bổ gia đình (allocation familiale)* ở Pháp) (Atkinson và Hills 1991).

Việt Nam đã có sẵn một hệ thống các chính sách bảo hiểm xã hội tương đối phức tạp qui định các nhóm đối tượng bảo hiểm xã hội, trợ giúp và cứu trợ theo tiêu chuẩn như áp dụng ở các nước phát triển hơn. Tuy nhiên phạm vi bao quát của các chương trình này lại cực kỳ hạn chế. Những hình thức bảo hiểm xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam, cũng như ở hầu hết các nước đang phát triển, đều thuộc dạng không chính thức và thực hiện thông qua các hệ thống xã hội gia đình và cộng đồng.

Ngoài ra, tác động tổng thể của các chương trình hiện nay lại mang tính chất luy thoái. Theo như minh họa trong Hình 1, việc chi trả phúc lợi xã hội – trong đó có trợ cấp, các dạng bảo hiểm khác, và chi trợ giúp xã hội – tăng lên theo thu nhập. Thực tế cho thấy trong thập kỷ qua các khoản chi trả cho các hộ giàu tăng nhanh hơn chi chuyển khoản cho người nghèo.

Hình 1: Thu nhập phúc lợi xã hội theo đầu người của Việt Nam tính theo nhóm ngũ phân vị chi tiêu giai đoạn 1993-2002 (nghìn đồng/năm)



Nguồn: TCTK

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các chính sách hiện có và xác định các nhân tố trong các chế độ hiện nay có thể kết hợp được vào hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất trong tương lai ở Việt Nam.

2.2.1. Các chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam có từ năm 1947. Ban đầu, hệ thống này chỉ hạn chế cho đối tượng cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà nước song năm 1993 hệ thống này đã được mở rộng cho cả các doanh nghiệp tư nhân và các công ty liên doanh. Chế độ bảo hiểm xã hội có đóng góp của Việt Nam giống như ở các nước đang phát triển khác. Trong các chương trình bắt buộc hiện nay có trợ cấp hưu trí, trợ cấp thương tật, trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp được bổ sung vào năm 2002. Những chương trình này do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện và mức đóng góp là 15% đối với chủ sử dụng lao động và 5% đối với người lao động.

Trên 80% chi phí của các chương trình này do chính phủ trung ương chi trả vì hệ thống bắt buộc thuộc quyền hạn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mới chỉ được đưa vào áp dụng năm 1995.² Bộ Luật Lao động ban hành năm 1994 và sửa đổi năm 2002 đã đưa ra qui định khuôn khổ phát triển bảo hiểm xã hội và đây là cơ sở để ban hành các nghị định chế độ bảo hiểm xã hội về trợ cấp và các dạng phúc lợi khác. Chính phủ đã có kế hoạch mở rộng chế độ này để có cả trợ cấp thất nghiệp và thương tật.

Cơ quan Bảo hiểm Y tế Việt Nam do chính phủ thành lập năm 1995 hiện bao quát khoảng 13% dân số. Trong cơ quan này có các chương trình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện trực thuộc Bộ Y tế. Mức đóng góp là 2% đối với chủ sử dụng lao động và 1% đối với người lao động. Bảo hiểm y tế tự nguyện mua theo thẻ thường có giá trị là một năm. Học sinh và sinh viên có thể tham gia chương trình bảo hiểm y tế tự nguyện và chính phủ cũng cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho các hộ rất nghèo theo CTMTQG và hiện nay cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi³. Việc trợ giúp chi phí bảo hiểm y tế cho người nghèo hiện nay được tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trợ cấp tiếp cận với bảo hiểm y tế và nhà nước chi trả trực tiếp cho các bệnh viện hoặc các bên cung cấp dịch vụ khác. Chăm sóc sức khỏe cơ bản được miễn phí song bệnh nhân phải thanh toán chi phí khi điều trị thêm và phải trả tiền thuốc. Chi tiêu công cho chăm sóc sức khỏe tính theo phần trăm ngân sách giảm đáng kể từ năm 1994, trong năm 2002 chỉ còn 3% (Bảng 3).

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không mang tính chất tái phân phối (Bảng 4).⁴ Hệ thống bảo hiểm xã hội chỉ đến được 11% lực lượng lao động và không tới được những người cần nhất. Đa số những người có bảo hiểm xã hội hiện nay thuộc về các nhóm thu nhập trung bình và thu nhập cao, nhất là các cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà nước vẫn còn làm việc và về hưu và người lao động ở khu vực chính thức (Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004). Không chỉ riêng ở Việt Nam mới có tình trạng này. Các chương trình bảo hiểm xã hội có thể bao gồm những yếu tố lũy tiến để người lao động có thu nhập thấp có được tỷ lệ lãi cao hơn đối với các khoản đóng góp của mình so với người lao động có thu nhập cao. Tuy nhiên, ở nhiều nước, các chương trình lại mang lợi ích đến cho các nhóm tương đối có đặc lợi như người trong quân đội và trong chính phủ, và vì thế không phát huy được tác dụng giảm bất bình đẳng (Midgley 1984; Mesa-Lago 1991).

Bảng 4: Mức trợ cấp trung bình của bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội (1998)

	Bảo hiểm xã hội		Trợ cấp xã hội	
	Tỷ lệ phần trăm được hưởng (%)	Mức trợ cấp trung bình (người/năm)	Tỷ lệ phần trăm được hưởng (%)	Mức trợ cấp trung bình (người/năm)
Nhóm ngũ phân vị thứ nhất	13,9	1.010.353	7,3	251.192
Nhóm ngũ phân vị thứ hai	12,1	903.628	10,0	175.030
Nhóm ngũ phân vị thứ ba	11,6	849.509	9,6	182.875
Nhóm ngũ phân vị thứ tư	9,1	745.967	9,4	181.074
Nhóm ngũ phân vị thứ năm	9,5	731.642	11,6	196.422

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2002).

² Tuy vậy, thậm chí sau năm 1995, nguồn quỹ từ các khoản đóng góp cũng rất ít vì tỷ lệ trốn đóng bảo hiểm cao. Phần thiếu hụt trong nguồn quỹ trợ cấp cho dân (trên một nửa tổng số) được bù bằng nguồn ngân sách chung từ thuế thu trong toàn dân trong khi đa phần người dân lại không tiếp cận được với bảo hiểm xã hội. Đã có nhiều nỗ lực để chuyển nguồn tài chính bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mới. Tuy nhiên trong năm 1999 chính phủ vẫn là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu (Ngân hàng Thế giới 2002).

³ Theo Điều 15.2 của Luật sửa đổi về Chăm sóc, Bảo vệ và Giáo dục Trẻ em (2004), tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được quyền chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Tuy nhiên, theo kết luận trong một đánh giá gần đây của UNICEF và Bộ Y tế, nguồn lực phân cho mục đích này không đủ và, do vậy, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các dịch vụ y tế dành cho trẻ em là miễn phí (UNICEF và Bộ Y tế 2005).

⁴ Trước đây có các chương trình bảo hiểm cây trồng song hiện nay bị dừng. Hiện đang nghiên cứu vấn đề bảo hiểm cây trồng và cũng đang xem xét các sáng kiến mở rộng đối tượng trợ cấp có đóng góp tự nguyện cho nông dân.

2.2.2. Các chính sách trợ giúp xã hội

Các chương trình trợ giúp xã hội hiện nay (chi chuyển khoản cho trợ giúp và cứu trợ) hỗ trợ hạn chế về tài chính theo các điều kiện chặt chẽ. Nguồn quỹ trợ giúp xã hội không đến được với tất cả người nghèo mà chỉ đến được với những người đang trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và chi tiêu của các chương trình này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi tiêu xã hội (ILO 1999a). Đối với trường hợp bảo hiểm xã hội thì các chương trình trợ giúp xã hội không mang tính lũy tiến, dù ít lũy thoái hơn bảo hiểm xã hội một chút (van de Walle 2003) (Bảng 4). Trong phần này mô tả tóm tắt năm dạng trợ giúp xã hội hiện áp dụng ở Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ xã hội dành cho cựu chiến binh, thương binh và những người có công với cách mạng

Một trong những hậu quả của 30 năm chiến tranh ở Việt Nam là nhà nước phải chịu trách nhiệm giúp đỡ các cựu chiến binh, gia đình họ và những người có công với cách mạng. Những đối tượng này được hưởng trợ cấp đặc biệt từ quỹ hỗ trợ xã hội dành cho cựu chiến binh và thương binh, đối tượng của quỹ này chiếm khoảng 2%-3% dân số. Các đối tượng hưởng trợ cấp của nhà nước và trợ cấp mất sức lao động chủ yếu cũng thuộc các nhóm này. Trợ cấp dành cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có các thương binh tàn tật và gia đình liệt sỹ, chiếm 35,3% (2,9 nghìn tỷ đồng) chi tiêu bảo trợ xã hội của chính phủ trung ương (ILO 1999a). Tỷ lệ này đã tăng lên từ 30,3% (1,5 nghìn tỷ đồng) trong năm 1994 (Prescott 1997).⁵

Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo (CTMTQG) và chương trình 135

CTMTQG về XDGN do Bộ LĐ-TBXH chủ trì gồm có 13 phần, trong đó có hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng (bên cạnh những lĩnh vực thuộc phạm vi Chương trình 135); trợ cấp tín dụng sản xuất; các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư; “định canh định cư” các đồng bào dân tộc vùng cao sống du canh du cư; hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở; và miễn giảm thuế nông nghiệp. Tín dụng trợ cấp thực hiện qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Chính sách Xã hội (trước năm 2003 được gọi là Ngân hàng cho Người Nghèo).

Chương trình 135 (hoặc nếu gọi chính thức là Chương trình Phát triển Kinh tế - Xã hội ở các Xã Đặc biệt Khó Khăn) do Ủy ban Dân tộc Miền núi (UBDTMN) quản lý và gồm có năm phụ phần. Tuy nhiên, phần lớn nguồn vốn được dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn và các “trung tâm cụm” xã.

Bộ LĐ-TBXH và UBDTMN là các cơ quan chủ trì của hai chương trình này. Tuy nhiên, có nhiều cơ quan khác tham gia thực hiện các chương trình này, trong đó có Bộ Y tế (hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe), Bộ Giáo dục và Đào tạo (miễn giảm học phí), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (khuyến nông và định canh định cư), và Ngân hàng Chính sách Xã hội (các chương trình tín dụng).⁶

Hai chương trình này, CTMTQG và Chương trình 135, đã dành nhiều nguồn lực cho các cộng đồng dân cư nghèo, và do nhiều xã mục tiêu nằm ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa và có nhiều dân tộc thiểu số nên có thể các chương trình này cũng đóng góp cho ổn định xã hội. Theo kết quả đánh giá gần đây của UNDP-Bộ LĐ-TBXH thì việc xác định các đối tượng hưởng lợi nói chung có kết quả và hầu hết những người được hưởng trợ giúp của các chương trình này trên thực tế rất nghèo (UNDP 2004). Các chương trình này có thiết kế và nguồn ngân sách để thực hiện trên toàn quốc, và với tinh thần “sở hữu quốc gia” một số nhà tài trợ đã bắt đầu hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính.

Xét về góc độ này, CTMTQG và Chương trình 135 là thành công đáng kể của đất nước. Những vấn đề khó khăn chủ yếu hiện nay là tỷ lệ đối tượng tham gia thấp và phân tán do có nhiều phần được bổ sung thêm. Ngưỡng nghèo của Bộ LĐ-TBXH sử dụng để xác định đối tượng nghèo thấp hơn nhiều so với ngưỡng nghèo “quốc tế” của Tổng cục Thống kê (TCTK) dựa vào Điều tra Mức sống Hộ Gia đình Việt Nam (ĐTMSHGĐVN).⁷ Theo đánh giá gần đây của UNDP-Bộ LĐ-TBXH, chỉ có 17% hộ gia đình Việt Nam tiếp cận được với trợ cấp tín dụng, và 70% số đó nằm trong danh sách các hộ nghèo của Bộ LĐ-TBXH. Dưới 10% hộ được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí và khoảng 20% được miễn giảm học phí.

⁵ Hiện chưa có số liệu cập nhật về chi tiêu.

⁶ Hệ thống quản lý hành chính này đang gặp phải một số khó khăn (UNDP-Bộ LĐ-TBXH 2004 và Phần 4 ở dưới).

⁷ Tỷ lệ nghèo tính theo đầu người năm 2002 theo ngưỡng nghèo của Bộ LĐ-TBXH là 13% trong khi theo ngưỡng của TCTK là 29%. Hiện chính phủ đang trong quá trình xây dựng một ngưỡng nghèo thống nhất tính theo mức chi tiêu hộ gia đình trong một tháng cho các khu vực thành thị và nông thôn.

Cũng theo đánh giá của UNDP-Bộ LĐ-TBXH, rất ít hộ nghèo được nhận tất cả các loại trợ cấp, do đó những người rất nghèo không nhất thiết hưởng lợi đến mức như dự kiến. Vì vậy CTMTQG không tạo ra một hệ thống an sinh xã hội có kết quả cho các hộ nghèo nhất. Trong đánh giá này cũng xác định các thiếu sót khác trong đó có vấn đề quản lý chương trình quá tập trung, hệ thống quản lý tài chính yếu kém (cụ thể là các cơ chế kế toán, kiểm toán và đánh giá), và cần giám sát có hiệu quả hơn.⁸

Quỹ hỗ trợ xã hội dành cứu trợ thường xuyên

Khoản trợ cấp hàng tháng chi từ quỹ hỗ trợ xã hội dành cứu trợ thường xuyên đến được khoảng 0,32% dân số, kể cả người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi và người nghèo bị thương tật nặng. Ngoài ra cũng có một phần nhỏ dành trợ giúp các đối tượng vô gia cư, hầu hết là trẻ em đường phố. Số người được hưởng lợi từ những chương trình này rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn lực và công tác quản lý chương trình yếu kém. Trong chương trình này và các chương trình tương tự khác - chẳng hạn như quỹ dự phòng cứu đói giáp hạt và cứu trợ thiên tai – nguồn tài chính từ trung ương không đủ, trong khi các chính quyền địa phương không thể bù được phần thiếu hụt. Do đó các đối tượng hưởng lợi dự kiến nhất lại không được cứu trợ cấp và ngay cả những người được trợ cấp thì trợ cấp cũng ít tới mức các chương trình không đạt được tác động như dự kiến. Mức trợ giúp cũng khác nhau theo từng tỉnh, huyện và thậm chí từng xã (ILO, 1999a). Vào cuối những năm 1990, những khoản chi này chỉ chiếm 0,3% tổng chi tiêu của chính phủ (ILO 1999a).

Quỹ dự phòng cứu đói giáp hạt và cứu trợ thiên tai

Mục tiêu chính của chương trình này là cứu trợ các vùng bị thiên tai và cứu trợ ngắn hạn cho người nghèo, thường bằng lương thực (hoặc tiền mặt để mua lương thực) trong thời kỳ đói giáp hạt. Trong năm 1997, chi tiêu của chính phủ cho cứu trợ thiên tai chiếm 2,4% (200 tỷ đồng) chi bảo trợ xã hội (ILO 1999a). So với năm 1994, tỷ lệ này đã giảm 7,9% (Prescott 1997). Cứu đói giáp hạt chiếm 1,2% tổng ngân sách chi bảo trợ xã hội năm 1997 (ILO, 1999a).⁹ Trong các chương trình này có những thiếu sót lớn, trong đó có việc sử dụng nguồn quỹ cho các mục đích khác khi không có thiên tai, nên không có đủ nguồn lực dự trữ khi thiên tai thực sự xảy ra. Quỹ dự phòng cứu đói giáp hạt và cứu trợ thiên tai là những hình thức trợ giúp xã hội duy nhất dành cho các hộ nghèo dù trên thực tế chỉ có khoảng một nửa số người xin cứu trợ thực sự được trợ giúp.¹⁰ Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Chính phủ Trung ương đã phân bổ khá nhiều nguồn lực cho các nỗ lực cứu trợ lương thực, nhất là sau cơn bão “Linda” năm 1997, các trận lũ lụt nặng nề ở miền Trung vào năm 1999, và lũ lụt trên diện rộng ở vùng đồng bằng sông Mê Kông năm 2000 and 2001. Theo kết quả đánh giá tổng kết các nỗ lực cứu trợ và khắc phục hậu quả sau các trận lụt ở vùng Đồng bằng sông Mê Kông, các hoạt động cứu trợ lương thực nói chung đủ và kịp thời. (Neefjes 2002).

Có nhiều nguồn tài chính được tạo thêm thông qua các kênh ở khu vực tư nhân, trong đó có các tổ chức quần chúng (với sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhất là sau các đợt thiên tai lớn. Một số nguồn tiền này được chuyển qua một uỷ ban *đặc biệt* ở cấp trung ương trong trường hợp xảy ra thiên tai lớn, song đa phần được chuyển trực tiếp cho các cơ quan hữu trách ở địa phương (cấp tỉnh và huyện) và các đơn vị cơ sở của các tổ chức quần chúng (chẳng hạn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Các cơ quan hữu trách ở địa phương còn sử dụng các khoản ngân sách cơ bản trong ngân sách thường xuyên dành cứu trợ và khắc phục hậu quả của mình; khi xảy ra thiên tai nhỏ thì đây có thể là nguồn tài chính duy nhất. Các khoản phân bổ thường dành cho cứu trợ trước mắt (lương thực và các vật phẩm khác), hỗ trợ phục hồi sinh kế (chẳng hạn thuyền, lưới), và xây dựng lại nhà cửa, cải thiện các phương tiện chống bão lụt. Những khoản giải ngân này nói chung dành cho các hộ dễ bị tổn thương nhất. Hiện chưa có số liệu toàn diện cấp quốc gia về lĩnh vực này (Neefjes 2002; Lempert và các tác giả 2004).

Các hình thức không chính thức

Các cơ chế bảo hiểm xã hội khác ở Việt Nam mang tính chất không chính thức, chẳng hạn như các thành viên trong gia đình hỗ trợ lẫn nhau, đổi công và giúp đỡ lẫn nhau về lương thực thực phẩm trong làng xóm láng giềng, các khoản vay trong gia đình, láng giềng và người cho vay nợ. Các hình thức không chính thức này cũng là biện pháp an sinh cho hàng triệu hộ gia đình Việt Nam.¹¹ Tuy nhiên, những hình thức này có chiều hướng không còn quan trọng như trước vì cấu trúc gia đình

⁸ Trong Neefjes (2004) và Minford và các tác giả (2004) cũng đưa ra những kết luận tương tự.

⁹ Chưa có những đánh giá gần đây về các chương trình này.

¹⁰ Những người xin cứu trợ có được trợ giúp hay không còn tùy thuộc vào địa điểm và các khoản chi khác của quỹ trong năm đó. (ILO 1999a).

¹¹ Xem ví dụ trong bài của Cox (2002).

thay đổi và lao động chuyển dịch nhiều hơn và phụ thuộc hơn vào làm công ăn lương. Ở những nước có tốc độ thay đổi về kinh tế và xã hội nhanh như ở Việt Nam nguy cơ sẽ là chính phủ sẽ tiếp tục dựa lâu dài vào các hình thức an sinh không chính thức sau khi đã mất năng lực bảo trợ đa phần người dân đối với các rủi ro về mức sống.

2.3. Các khó khăn và thách thức tiềm ẩn

Trong quá trình xây dựng các hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển gặp phải nhiều vấn đề giống nhau. Việt Nam cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Tỷ lệ đối tượng tham gia thấp là hạn chế căn bản nhất đối với các chương trình bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam cũng như ở các nước đang phát triển khác. Khó khăn về tài chính thường được coi là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tham gia thấp. Tuy nhiên, như trình bày trong các phần dưới, cách lý giải này không mang tính thuyết phục như lúc thoáng nghe qua. Những khác biệt về cơ cấu giữa các nước đang phát triển và các nền kinh tế tiên tiến hơn thường đóng vai trò quan trọng hơn. Trong số đó có các vấn đề do các hệ thống tài chính chưa phát triển (nhất là các thị trường vốn và bảo hiểm), những hạn chế về tổ chức và hành chính, và sự tồn tại dai dẳng của các cơ cấu thị trường lao động truyền thống.

2.3.1. Khó khăn về tài chính

Các nước đang phát triển phải đối mặt với khó khăn về tài chính và tình hình càng tồi tệ hơn vì năng lực thu thuế và giải quyết các thất bại của thị trường của chính phủ có hạn (Newbery và Stern 1987). Các nhóm có thu nhập cao cố gắng trốn thuế, trong đó có các khoản đóng bảo hiểm xã hội, vì họ không mong chờ được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình của chính phủ dành trợ giúp người nghèo (Becker, Büchner và Sleeking 1987). Ở Việt Nam tình hình cũng như vậy (Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004). Sự thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu và các thị trường tài chính kém phát triển cũng là đặc điểm phổ biến ở các nước đang phát triển làm cho chính phủ ở các nước này gặp nhiều khó khăn hoặc không thể cấp ngân sách cho bảo hiểm xã hội. Quan điểm của nhiều người cho rằng các nước như Việt Nam không thể có khả năng tài chính để thực hiện các chương trình bảo hiểm xã hội, và vì thế các chương trình bảo hiểm xã hội không phù hợp với các nhu cầu xã hội và kinh tế ở các nước này, phần lớn là những quan điểm nhìn nhận những khó khăn về tài chính là những khó khăn mang tính chất trói buộc và không thể tránh được.

Thế nhưng, theo Drèze và Sen (1991), Burgess và Stern (1991), Guhan (1992) và một số học giả khác, thì thực tế lại không chứng minh được cho suy đoán này của nhiều người. Dù có thể là không sao chép ngay lập tức một số chương trình phức tạp và tốn kém thực hiện ở các nước thu nhập cao cho các nước nghèo, song vẫn có nhiều phương án khác nhau vừa thực tế vừa khả thi về tài chính. Có thể thấy một loạt ví dụ ở các nước có điều kiện rất khác nhau như Trung Quốc, Côsta Rica, Chilê, Cuba và Xri Lanca. Các nước này đã thực hiện thành công các chương trình bảo hiểm xã hội với chi phí tương đối thấp vì có mức lương thấp song lại có cam kết mạnh mẽ của người dân, và quản lý hành chính hiệu quả (Drèze và Sen 1991) (xem Khung 1). Ngoài ra, ở các nước đang phát triển, lợi ích và chi phí tài chính rất khác so với lợi ích và chi phí xã hội. Chi phí và lợi ích xã hội có tính đến các yếu tố không hoàn hảo của thị trường trong đó có các yếu tố ngoại lai tích cực và tiêu cực.¹² Cần phải xem xét cẩn thận những tác động trên toàn nền kinh tế này trước khi ước tính lợi ích và chi phí thực sự của việc đầu tư vào bảo hiểm xã hội (Midgley 1984; Atkinson và Hills 1991; Drèze và Sen 1991).

Khung 1: Chi phí chương trình xét trên quan điểm quốc tế

Dev (1996) tính toán rằng chi của chính phủ trung ương và chính quyền bang cho các dịch vụ phát triển nông thôn và xã hội ở Ấn Độ chiếm 6,9% GDP trong năm tài khoá 1993/1994, hoặc 7,3% nếu tính cả trợ cấp lương thực. Tuy nhiên, theo Guhan (1992), nếu Ấn Độ thực hiện hệ thống bảo hiểm xã hội tương đối toàn diện của Tamil Nadu trên toàn quốc thì chi phí chỉ chiếm từ 0,3 đến 0,5% GDP. Những nước như Trung Quốc, Xri Lanca, và Cuba đã cải thiện đáng kể tình hình đáp ứng các nhu cầu cơ bản, giáo dục và y tế với chi phí thấp so với thu nhập quốc dân; tỷ lệ phần trăm GDP dành cho chi tiêu công đối với y tế ở Trung Quốc vào những năm 1980 là 2%, ở Xri Lanca năm 1981 là 1% và trong cùng thời gian ở Cuba là 2,7% (Drèze và Sen 1991: 27). Do đó, Drèze và Sen cho rằng các nền kinh tế này thực hiện thành công các chương trình tái phân phối 'không phải do qui mô của các khoản phân bổ tài chính cho các lĩnh vực công nhất định. Thành công thực sự dường như do tạo ra được các điều kiện chính trị, xã hội và kinh tế để quyết tâm thực hiện có kết quả các chương trình trợ giúp người dân đầy tham vọng và có thể hướng tới các nhóm dân cư nghèo khó' (trang 28).

¹² Xem Mục 2.4.

Thay đổi về nhân khẩu

Trong quá trình tăng trưởng ở các nước có những thay đổi trong dạng thức sinh tử. Nói chung người dân có tuổi thọ cao hơn do cải thiện mức sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Do đô thị hoá, trình độ học vấn và có khả năng tiếp cận với các biện pháp phòng tránh thai nên tỷ lệ sinh giảm. Kết quả là tỷ lệ người nhiều tuổi trong dân số tăng. Những thay đổi về mặt nhân khẩu như vậy làm tăng dần sức ép đối với các cơ chế bảo hiểm xã hội ở các nước phát triển. Với các hệ thống trả khi đến lượt (pay-as-you-go system)^{*}, khi dân số già đi có thể có nghĩa là các thế hệ trẻ hơn khi về già sẽ nhận được ít hơn so với mức họ phải đóng góp bây giờ bằng hình thức đóng bảo hiểm xã hội (xem Myles 1995). Dù có các phương án khác thay cho các hệ thống trả khi đến lượt, chẳng hạn như các hệ thống hoàn toàn dựa vào nguồn quỹ (fully-funded) hoặc bảo hiểm tuổi già và y tế dạng bán tư nhân, song các nước đang phát triển thấy khó thực hiện các phương án này. Chính trị là một yếu tố quan trọng vì các đối tượng hưu trí hiện nay đã hình thành các nhóm lợi ích có tổ chức và có tiếng nói ngày càng mạnh. Vì thế chính phủ ở các nước công nghiệp thường phải chấp nhận buộc đưa ra các quyết định không được lòng dân nhằm mục đích tăng nguồn tài chính cho các chương trình bảo hiểm xã hội. Các nước đang phát triển như Việt Nam cần học hỏi những kinh nghiệm này và thiết kế các chương trình bền vững về mặt tài chính trong dài hạn.

Thị trường tài chính ở các nước đang phát triển

Có một vấn đề nan giải hơn nữa là các thị trường tài chính ở Việt Nam chưa hoàn chỉnh và có khi không có. Các thị trường bảo hiểm tư nhân trong nước rất kém đã đặt gánh nặng lên các hệ thống bảo hiểm xã hội của nhà nước và đặt ra một câu hỏi quan trọng về ảnh hưởng của bảo hiểm xã hội đối với tiết kiệm và đầu tư. Những ảnh hưởng này liên quan trực tiếp đến các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo học thuyết kinh tế, các hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ không ảnh hưởng đến tiết kiệm (vì vậy không ảnh hưởng đến lượng vốn) khi áp dụng các điều kiện sau: i) lợi tức bằng kỳ vọng của mức đóng góp; ii) mức đóng góp không vượt mức tiết kiệm tự nguyện (đây là trường hợp xảy ra với hầu hết các hệ thống hoàn toàn dựa vào nguồn quỹ); và iii) lãi suất bằng mức tăng tổng lương. Tuy nhiên, nếu hệ thống này có thiết kế là một chương trình tiết kiệm bắt buộc để người tiêu dùng được hưởng các khoản thu nhập lớn hơn trong tương lai thì hệ thống này sẽ khuyến khích tiết kiệm và như vậy sẽ tăng được lượng vốn dành cho nền kinh tế (Myles 1995).

Tuy nhiên, nếu trợ cấp cao hơn mức đóng góp (đây là trường hợp xảy ra với một số hệ thống trả khi đến lượt), các trợ cấp bảo hiểm xã hội có thể được coi là một khoản tăng lương có thật và vì thế kích thích tiêu dùng hiện tại. Feldstein (1974) quả quyết đã thấy hiện tượng này qua kinh nghiệm ở Mỹ còn Takayama (1992) thấy ở Nhật Bản. Tình trạng người dân còn thiếu tin tưởng do thiếu thị trường tài chính hoặc thị trường tài chính không hoàn chỉnh ở các nước đang phát triển có xu hướng làm cho những ảnh hưởng này trở nên nặng nề hơn.

2.3.2. Hạn chế về quản lý hành chính

Ở các nước đang phát triển có thể còn có các vấn đề khác nữa, trong đó có hiệu quả quản lý hành chính kém, thiếu cán bộ được đào tạo thích hợp, và trình độ dân trí thấp. Những yếu tố này đã ngăn cản người dân xin trợ cấp trong phạm vi quyền lợi của mình (Midgley 1984). Hệ thống luật bảo hiểm xã hội quá phức tạp có thể làm cho những vấn đề này càng phức tạp hơn. Theo đánh giá gần đây về CTMTQG (UNDP-Bộ LĐ-TBXH 2004), Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những vấn đề này.

Công tác hành chính và quản lý kém hiệu quả làm tăng chi phí của các chương trình bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển (Mesa-Lago 1983). Ở những nước không có hệ thống bảo hiểm xã hội duy nhất dựa trên cơ sở hệ thống luật pháp rõ ràng và thống nhất, có nguồn tài chính và quản lý hành chính độc đáo, và hoạt động tài chính và trợ cấp đồng bộ thì lại càng kém hiệu quả. Đơn giản hoá thủ tục đăng ký, quản lý hồ sơ và công tác thu sẽ giảm được chi phí hành chính và bớt áp lực cho các cơ quan nhà nước. Từ đó công tác quản lý hành chính tốt sẽ có thể giảm bớt sự phản đối chính trị khi thực hiện các chương trình bảo hiểm xã hội. Đây là một nhân tố quan trọng cần nghiên cứu ở Việt Nam vì nếu giảm được tình trạng người có thu nhập trốn đóng góp sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng tài chính của các chương trình bảo hiểm xã hội đè lên vai phần đông dân số. Chúng ta sẽ

^{*} Hệ thống này có nghĩa là người sử dụng đóng góp cho chính phủ, sau đó chính phủ sẽ chi trả cho các chi phí y tế và trợ cấp từ ngân sách của nhà nước (N.D.)

quay trở lại vấn đề này khi bàn về cách thức tổ chức hành chính ở Việt Nam trong phần cuối của văn kiện này.

2.3.3. Cơ cấu lao động

Đối với những nước như Việt Nam, cấu trúc thị trường lao động cũng là một hạn chế đối với quá trình thực hiện các hệ thống bảo hiểm xã hội. Gần 60% lực lượng lao động ở Việt Nam làm nông nghiệp. Đây là một ngành có thu nhập biến động, năng suất lao động thường thấp và thường xuyên thiếu việc làm. Vì thế nên đối tượng của các chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay mới chỉ là các cán bộ công nhân viên nhà nước, và người lao động trong khu vực bán chính phủ và trong các doanh nghiệp tương đối lớn, có đăng ký theo hợp đồng lao động thường xuyên.¹³ Mở rộng phạm vi đối tượng của bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội hiện nay cho đa phần dân số là một thách thức lớn trong tương lai. Để đạt được tiến bộ tiến tới một hệ thống mang tính toàn dân hơn cần phải xem xét cẩn thận mặt chi phí so với lợi ích về mặt kinh tế, xã hội và chính trị.

Có một vấn đề liên quan là mối quan hệ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội, các biện pháp khuyến khích lao động và sự cần thiết phải tránh phụ thuộc vào chi chuyển khoản của chính phủ ở những đối tượng có khả năng lao động. Chẳng hạn, các chính sách bảo hiểm xã hội có thể tác động đến nguồn cung lao động bằng cách hạ thấp độ tuổi về hưu hoặc tăng thời gian thất nghiệp (Atkinson và Stiglitz 1981). Nếu có thị trường vốn hoàn hảo, phí bảo hiểm đóng góp sẽ bằng mức tiết kiệm mong muốn, và người lao động có thể vay với lãi suất ngang bằng với mức sử dụng để tính trợ cấp bảo hiểm xã hội (Aaron 1982). Khi những giả thiết này không đúng thì chính sách bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng đến các quyết định tiêu dùng, tiết kiệm và nguồn cung lao động, ngay cả khi đóng góp bằng trợ cấp. Ở những nước như Việt Nam có các thị trường vốn và bảo hiểm chưa hoàn hảo, cần phải điều chỉnh giá trị trợ cấp để giảm thiểu các biện pháp khuyến khích về mặt kinh tế mang tính tiêu cực và tránh sự phụ thuộc không xác đáng vào chi chuyển khoản của chính phủ. Các luật qui định tuổi nghỉ hưu tối thiểu cần khuyến khích người lao động có tuổi tiếp tục ở lại trong lực lượng lao động. Các hệ thống hoàn toàn dựa vào nguồn quỹ cũng là một phương án có thể đứng vững được vì theo các hệ thống này các khoản trợ cấp và tiết kiệm tư nhân có tính chất thay thế nhau và trong đó mức trợ cấp xã hội bằng tiết kiệm tư nhân. Trong trường hợp này, việc chi trả trợ cấp không làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng (Atkinson và Stiglitz 1981). Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này trong phần cuối của văn kiện.

2.4. Cơ hội tiềm ẩn nhờ các chính sách bảo hiểm xã hội

Như đã trình bày trong phần trên, nhiều tác giả cho rằng các nước đang phát triển nên trì hoãn việc thiết lập các hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, với lý do về tình hình bảo hiểm xã hội ở các nước công nghiệp và điều kiện kinh tế ở các nước đang phát triển hiện nay. Quan điểm của nhiều người cho rằng ở nhiều nước đang phát triển do điều kiện nghèo cùng cực đã buộc một bộ phận dân số lớn phải tìm cách được bảo trợ chống lại các rủi ro hiệp biến ngắn hạn (nói cách khác là những mối đe dọa trước mắt đối với cuộc sống như mất mùa) hơn là phân đều thu nhập theo thời gian hoặc giữa các thế hệ (xem Ahmad và các tác giả 1991). Lập luận ở đây là các nước có khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao và có tỷ lệ lực lượng lao động cao sống dựa vào lao động mùa vụ hoặc lao động trong khu vực không chính thức (và vì thế thu nhập rất không ổn định) sẽ không thích hợp với việc phát triển các hệ thống bảo hiểm xã hội chính thức. Năng lực hành chính có hạn cũng được coi là một trở ngại chính đối với việc thực hiện các mạng lưới an sinh xã hội và các công cụ bảo hiểm xã hội. Cuối cùng, những người phản đối bảo hiểm xã hội cho rằng cơ cấu chính trị ở các nước đang phát triển không thuận lợi cho các chính sách mang tính chất lũy tiến có bao hàm biện pháp nào đó để tái phân phối thu nhập.

Văn kiện này theo quan điểm cho rằng những lập luận trên đã quá nhấn mạnh vào các mặt tiêu cực của bảo hiểm xã hội ở các nước giàu và chưa chú ý đúng mức đến những tiềm năng đóng góp tích cực cho tăng trưởng, bình đẳng, gắn kết xã hội và ổn định chính trị ở các nước đang phát triển. Đối với việc thiết lập các chương trình bảo hiểm xã hội ở những nước như Việt Nam cần phải dựa vào việc đánh giá một cách cân đối hơn cả mặt lợi ích và chi phí của các hệ thống này. Những nước như Việt Nam có thể học được những bài học quý giá từ quá trình phát triển các hệ thống bảo hiểm xã hội ở các nước phát triển và tránh được những thiếu sót trong các hệ thống này.

¹³ Xem thêm ví dụ về châu Phi trong Midgley (1984); Ahmad và các tác giả (1991); Mouton (1975) và về châu Mỹ Latinh trong Mesa-Lago (1991). Trong Bộ Luật Lao động của Việt Nam có qui định về các cán bộ công chức nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp có trên 10 lao động.

Những nước như Chilê, Trung Quốc, Côxta Rica, Cuba, Jamaica, Xri Lanca và bang Kerala ở Nam Ấn Độ đã thực hiện các hệ thống bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở xác định đối tượng có hiệu quả, phạm vi đối tượng tham gia rộng và xem xét cẩn thận các đặc điểm cụ thể của nền kinh tế địa phương. Các hệ thống này phần lớn thành công trong việc bảo trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất tránh bị nghèo cùng cực trong quá trình công nghiệp hoá cũng giống như các chương trình bảo hiểm xã hội đã đóng vai trò căn bản trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở các nước công nghiệp hiện nay trong nửa đầu thế kỷ 20.

Khi tính toán các lợi ích và chi phí của các chương trình bảo hiểm xã hội, cần xem xét các tác động bên ngoài, hay nói một cách khác, là những tác động kinh tế mà thị trường hoặc giá cả thực tế không giải quyết được. Trong số đó có:

- i. Tốc độ hình thành vốn nhân lực tăng do cải thiện giáo dục và chăm sóc sức khỏe (Saint-Paul và Verdier 1992; Perotti 1993) và xoá bỏ các dạng nghèo cùng cực;
- ii. Hiệu ứng phụ về phía cầu do tái phân phối sức mua cho các đối tượng tiêu dùng nào dành nhiều thu nhập hơn để mua các hàng hoá và dịch vụ sản xuất trong nước so với hàng nhập khẩu (Murphy và các tác giả 1989);
- iii. Thúc đẩy ổn định xã hội và chính trị vì lợi ích của tăng trưởng kinh tế tác động rộng hơn trong toàn dân nên làm giảm sự bất mãn về xã hội và chính trị (Alesina và Perotti 1993).

Những tác động này bắt nguồn từ các tính chất tái phân phối của các chính sách bảo hiểm xã hội. Học thuyết phát triển chủ đạo của những năm 1970 đã nhấn mạnh các ý nghĩa tích cực về xã hội và chính trị của 'tái phân phối với tăng trưởng' (Chenery và các tác giả 1974), song vào những năm 1980, các chính sách này không còn được ưu ái nữa vì các nước đang phát triển phải vật lộn để vượt qua được các cơn sốt tài chính do khủng hoảng nợ và giá cả hàng hoá tụt xuống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây lại thấy người ta quan tâm trở lại vấn đề tái phân phối vì các nhà kinh tế cố gắng giải thích về thành tựu ưu việt của các nước Đông Á so với các nước châu Mỹ Latinh và Châu Phi cận Sahara. Sự chú trọng trở lại đối với công tác giảm nghèo của các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức tài trợ khác cũng làm dấy lên câu hỏi liên quan đến các thành phần và qui mô thích hợp đối với các mạng lưới an sinh xã hội ở các nước đang phát triển. Dù không có giải pháp chung cho các vấn đề nghèo và bất an ninh, song những nước như Việt Nam có thể rút ra được những bài học quan trọng từ kinh nghiệm của các nước công nghiệp và nhiều nước đang phát triển khác đã từng thử nghiệm các cơ chế bảo hiểm xã hội khác nhau do nhà nước chỉ đạo để giảm bất bình đẳng, thiệt thòi, và thúc đẩy tăng trưởng.

3. Khái niệm bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Các phần trên cho thấy Việt Nam sẽ có lợi khi chuyển sang một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét câu hỏi hệ thống này nên tổ chức theo hình thức như thế nào. Để giải quyết câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần định nghĩa khái niệm bảo hiểm xã hội một cách cụ thể hơn. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã đưa ra một định nghĩa về bảo hiểm xã hội được chấp nhận rộng rãi nhất, định nghĩa này được phát triển dần theo thời gian dựa trên cơ sở nhiều hội thảo, hội nghị, thỏa thuận và công ước quốc tế. Theo định nghĩa của ILO thì:

Bảo hiểm xã hội là hình thức bảo trợ mà xã hội dành cho các thành viên của mình thông qua nhiều biện pháp công nhằm tránh tình trạng khốn khó về mặt kinh tế và xã hội do bị mất hoặc giảm đáng kể thu nhập vì bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động và tử vong; chăm sóc y tế; và trợ cấp cho các gia đình có con nhỏ (ILO 1984).

Định nghĩa về bảo hiểm xã hội này giống với Việt Nam và được thảo luận nhiều trong các đối thoại hiện đang tiến hành giữa chính phủ và ILO và trong các dự án cụ thể có sự hỗ trợ của các bên đối tác quốc tế khác, trong đó có GTZ, Ngân hàng Thế giới, và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Có nhiều tác giả đã đưa ra các định nghĩa khác về bảo hiểm xã hội hoặc bảo trợ xã hội áp dụng riêng cho các điều kiện ở các nước đang phát triển (ví dụ như Ahmad 1991; Ahmad và Hussain 1991; Burgess và Stern 1991; Schmidt 1995; Norton, Conway và Foster 2001; Kabeer 2002; Barrientos và Shepard 2003). Các tác giả này có chung một quan điểm là bảo hiểm xã hội không chỉ dừng ở việc mất đột ngột thu nhập theo dự kiến mà còn tính đến cả việc ngăn chặn và giảm nghèo kinh niên và mang lại mức sống tối thiểu.

Cách tiếp cận bảo hiểm xã hội mà mỗi nước lựa chọn còn tùy thuộc vào mục tiêu chính sách quốc gia và điều kiện cơ cấu cụ thể của nền kinh tế. Có một số nghiên cứu hiện nay đã đề cập đến các mặt khác nhau trong bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (ILO 1999a; Ngân hàng Thế giới 2002; Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004). Trong quá trình thảo luận xem xét thiết kế giai đoạn sau của CTMTQG cũng đã chuyển trọng tâm trở lại các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên vẫn cần có một chiến lược cho tương lai của bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong trung hạn đến dài hạn dựa trên một hệ thống mục tiêu chính sách gắn kết. Yêu cầu này phản ánh tình trạng lúng túng do có nhiều định nghĩa về bảo hiểm xã hội hoặc bảo trợ xã hội do các tổ chức quốc tế và trong nước đưa ra, trong đó có nhiều định nghĩa quá rộng hoặc quá chung không thể áp dụng trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Các định nghĩa khác nhau này phản ánh không chỉ tầm nhìn khác nhau về phát triển bảo hiểm xã hội ở Việt Nam mà còn phản ánh cách diễn giải khác nhau đối với các kinh nghiệm quốc tế và ý nghĩa của những kinh nghiệm đó đối với quá trình hoạch định chính sách quốc gia.

Nói như vậy không có nghĩa là quá trình thảo luận ở Việt Nam từ trước tới nay không có tác dụng gì. Quá trình đối thoại chính sách về định nghĩa thích hợp nhất cho bảo hiểm xã hội ở Việt Nam có ích ở chỗ đã góp phần nêu bật lên một số vấn đề chính. Thứ nhất là cần phải phân biệt sự khác nhau giữa các chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách giảm nghèo. Điểm thứ hai có liên quan là cần phải xác định rõ các đối tượng hưởng lợi dự định của các chương trình và chính sách này. Thứ ba, cần phải chú ý đến vai trò thích hợp của nhà nước trong việc cung cấp các chương trình bảo hiểm xã hội. Cuối cùng, cần xem xét cẩn thận tính chất tái phân phối của chính sách bảo hiểm xã hội trong bối cảnh nước đang phát triển

3.1. Sự khác nhau giữa các chính sách bảo hiểm xã hội và giảm nghèo

Mục tiêu chính của các chính sách bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển ngầm hiểu trong các văn bản là giảm bớt các hình thức nghèo và dễ bị tổn thương cùng cực. Các định nghĩa về bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển thường rộng và làm cho bảo hiểm xã hội được coi là đồng nhất với các chính sách chống nghèo chẳng hạn như các chính sách tạo tài sản (như các chương trình Phát triển Nông thôn Lồng ghép ở Ấn Độ) và các chương trình tạo việc làm (như Chương trình Đảm bảo Việc làm ở Maharashtra, Ấn Độ, và Chương trình Lương thực vì Việc Làm ở Bangladesh).¹⁴ Theo cách hoạch định này thì bảo hiểm xã hội được coi là đồng nhất với các 'mạng lưới an sinh xã hội'

¹⁴ Sự hấp dẫn của khái niệm "bảo trợ xã hội" đối với các nhà kinh tế học trường phái chủ đạo đã phản ánh quan điểm hạn chế này về vai trò của nhà nước trong giảm nghèo và cung cấp bảo hiểm xã hội.

Đúng là các hệ thống bảo hiểm xã hội có làm giảm nghèo và đóng góp cho các chiến lược giảm nghèo quốc gia khi kết hợp với các chính sách như các chương trình tạo việc làm, đầu tư công vào các cơ sở hạ tầng, các chính sách giáo dục và đào tạo để tạo khả năng tiếp cận bình đẳng hoặc ưu đãi cho người nghèo. Tuy nhiên, mục tiêu chính của bảo hiểm xã hội không phải là đưa các hộ gia đình và cá nhân khỏi ngưỡng nghèo mà là bảo vệ họ chống lại các rủi ro kinh tế và xã hội.¹⁵ Trên thực tế có nhiều chương trình chẳng hề tập trung vào đối tượng rất nghèo, mà dự định bao quát các nhóm dân cư cụ thể vì lý do nào đó bị loại khỏi lực lượng lao động chẳng hạn như người bị mất sức lao động hoặc về hưu.

Về mặt khái niệm, không có gì ngăn cản các nước đang phát triển áp dụng các hệ thống bảo hiểm xã hội tương tự như của các nước giàu ở nước mình. Việt Nam đã sẵn có hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (trong đó có bảo hiểm y tế), chi chuyển khoản cho trợ giúp xã hội và các chính sách cứu trợ theo đối tượng. Tuy nhiên, những nước như Việt Nam phải giải quyết các vấn đề thiết kế cụ thể trong quá trình xây dựng các chương trình bảo hiểm xã hội. Chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề cần quan tâm về khái niệm này trong mục sau của phần này và trong Phần 4 sẽ chuyển sang các vấn đề thực hiện trên thực tế.

3.2. Đối tượng các chính sách bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển

Theo định nghĩa của ILO về bảo hiểm xã hội, đối tượng bảo hiểm xã hội là người lao động bị 'mất hoặc giảm đáng kể thu nhập' vì bệnh tật, thai sản, mất sức lao động hoặc tuổi già. Những người lao động này đã đóng một phần tỷ lệ thu nhập của mình trong thời gian còn lao động cho các quỹ bảo hiểm xã hội, và với những khoản đóng góp này họ có quyền được hưởng trợ cấp giúp họ duy trì mức sống trong những trường hợp xảy ra sự cố như đã nói ở trên.

Ở Việt Nam và các nước đang phát triển khác các chính sách bảo hiểm xã hội không thể chỉ tập trung vào người đang làm việc vì có một bộ phận lớn dân số là lao động tự do hoặc lao động tạm thời trong khu vực không kê khai. Với những người này, rủi ro kinh tế luôn rình rập trong cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ xảy ra khi có những sự kiện nào đó trong đời như tai nạn hay bệnh tật. Ngoài ra, người đang làm việc trong khu vực chính thức ở các nước đang phát triển có thể khá giả hơn nhiều so với những người làm việc trong ngành nông nghiệp qui mô nhỏ hoặc các hình thức tự sản xuất hoặc lao động làm công ăn lương tạm thời khác.

Do đó, các chính sách bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển phải mở rộng đối tượng tham gia không chỉ ở khu vực chính thức mà còn cho cả lao động trong khu vực không kê khai và các nhóm dễ bị tổn thương khác (Jhabvala 1998). Ở Việt Nam, trong số các nhóm này có các đối tượng ngoại tỉnh đến sống ở các thành thị, đồng bào dân tộc thiểu số và các cá nhân thuộc đối tượng nghèo kinh niên rất dễ bị ảnh hưởng khi có thay đổi về xã hội và kinh tế (chẳng hạn đối tượng người già không được sử dụng nguồn thu nhập của những người trẻ hơn trong gia đình, người tàn tật, và trẻ mồ côi). Những đối tượng này đã nằm trong CTMTQG. Tuy nhiên, các chương trình này chỉ dành cho các đối tượng dưới 'ngưỡng nghèo lương thực' thấp và như vậy không tính đến nhiều đối tượng cá nhân và hộ gia đình dễ bị tổn thương. Nếu mở rộng các chương trình bảo hiểm xã hội cho những nhóm đối tượng này lại đặt ra các vấn đề về phân bổ nguồn lực trên thực tế và các vấn đề này sẽ được giải quyết dưới đây.¹⁶

3.3. Vai trò của nhà nước

Chính phủ có truyền thống từ lâu là quản lý các chương trình bảo hiểm xã hội và giảm nghèo. Có hai cơ sở lý thuyết logic về sự tham gia của nhà nước vào việc cung cấp bảo hiểm xã hội. Thứ nhất, bảo hiểm xã hội được coi là một hàng hoá công cộng, hay nói một cách khác là một hàng hoá hoặc dịch vụ sẽ sản xuất không đủ nếu để cho khu vực tư nhân thực hiện. Chỉ nhà nước mới có thể tạo ra được các động cơ khuyến khích cần thiết để tăng lượng cung của các công cụ bảo hiểm xã hội, hoặc buộc cá nhân tham gia các hệ thống bắt buộc. Ngoài ra, chính phủ quan tâm hơn khu vực tư nhân đến việc lập và cung cấp thông tin về các rủi ro kinh tế và khả năng tổn thương. Lý do thứ hai giải thích sự tham gia của nhà nước là các thất bại của thị trường là do chưa có các thị trường vốn, kỳ hạn và bảo hiểm hoặc nếu có thì yếu kém.

¹⁵ Trong Ahmad và các tác giả (1991), Guhan (1994) và Sinha và Lipton (1999) có thảo luận chi tiết về các rủi ro khác nhau đối với người nghèo.

¹⁶ Xem Mục 4.3.

Hai lập luận lý thuyết trên về vai trò của nhà nước trong việc cung cấp bảo hiểm xã hội phù hợp với những nước đang ở giai đoạn phát triển như của Việt Nam hiện nay. Do các thị trường vốn và bảo hiểm chưa hoàn chỉnh nên đa phần dân số phải đối mặt với các rủi ro kinh tế có liên quan đến bệnh tật, mất mùa, giá cả biến động, v.v... Và vì rủi ro xảy ra phổ biến ở tất cả các bộ phận trong xã hội nên xét trên quan điểm xã hội, các chi phí xã hội và chính trị có thể cực kỳ lớn.

Các hình thức dựa trên cơ sở gia đình và cộng đồng cũng tạo ra dạng bảo hiểm xã hội nào đó để phòng ngừa những tình huống và bất trắc xảy ra trong cuộc sống ở các nước đang phát triển kể cả Việt Nam.¹⁷ Tuy nhiên, có hai vấn đề phát sinh có liên quan đến việc cung cấp bảo hiểm xã hội không chính thức. Thứ nhất là các gia đình và cộng đồng thường phải đối mặt với những rủi ro như nhau vào cùng thời điểm (chẳng hạn thời tiết xấu, giá cả thay đổi hoặc bệnh truyền nhiễm). Do vậy, các hệ thống bảo hiểm không chính thức có thể thất bại khi cần nhất (Burgess và Stern 1991; Platteau 1991; và Ahmad 1991).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những hình thức dựa vào gia đình và làng xã theo truyền thống đang mất đi trong quá trình hiện đại hoá và đô thị hoá (Ngân hàng Thế giới 1994).¹⁸ Các hệ thống không chính thức đang giảm dần là một thách thức lớn về mặt thể chế và tài chính đối với các nước đang phát triển. Những nước như Việt Nam cần phải tìm cách thay thế các hệ thống truyền thống bằng các hệ thống chính thức thường do nhà nước chỉ đạo trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá trong khi các nguồn lực tài chính và kỹ thuật của nhà nước có hạn và tập trung vào các ưu tiên cạnh tranh lẫn nhau.

Do hạn chế về ngân sách nên chính phủ cần phải xác lập ưu tiên rõ ràng đối với bảo hiểm xã hội và xác định cẩn thận thứ tự mục tiêu ưu tiên. Chẳng hạn, kế hoạch tiết kiệm bắt buộc đối với khu vực tư nhân của Chile (xem Khung 2) hạn chế vai trò qui định của nhà nước. Trong trường hợp này, chính phủ đã quyết định tập trung vào các cơ chế giám sát và thực thi để đảm bảo việc thực hiện chương trình.

Một phương án chiến lược khác nữa là củng cố các mối quan hệ bảo hiểm xã hội không chính thức. Chẳng hạn chính phủ có thể trợ cấp cho các gia đình và cộng đồng chăm sóc người cao tuổi và người bệnh. Những chương trình này quản lý về mặt hành chính đơn giản hơn và chi phí thấp hơn so với khi chính phủ trực tiếp thực hiện dịch vụ. Ngoài ra, Drèze và Sen cũng cho rằng 'sự tham gia tích cực của người dân có thể có tác dụng vừa thu hút sự quan tâm chú ý của chính phủ đến các vấn đề nhẽ ra có thể bị lãng quên vừa thúc ép chính phủ can thiệp bằng cách làm cho chính phủ về mặt chính trị không thể phớt lờ những mối đe dọa sắp xảy ra - hoặc ít nhất cũng thấy được thể là đại đột' (1991: 29). Các chính sách bảo vệ tài sản khác cũng có thể bổ sung cho bảo hiểm xã hội. Cải cách ruộng đất, các chính sách khuyến khích tự tạo việc làm và làm công ăn lương, chính sách về mức lương tối thiểu, và trợ giúp lương thực, bản thân các biện pháp này cũng chưa đủ để thay thế cho chính sách bảo hiểm xã hội, song có thể là một bộ phận trong chiến lược tổng quát hơn của chính phủ để giảm rủi ro kinh tế cho các bộ phận dễ bị tổn thương nhất trong dân số (xem Osmani 1991 và Guhan 1994).

3.4. Bản chất lũy tiến của các chính sách bảo hiểm xã hội

Tái phân phối là một thành phần rõ ràng trong các chương trình bảo hiểm xã hội ở các nước châu Âu, và ở Bắc Mỹ dù mức độ ít hơn. Các chương trình này tái phân phối thu nhập bằng hai cách. Thứ nhất, các chương trình trợ giúp xã hội thường có nguồn quỹ từ thuế nên có thể chi chuyển khoản tiền mặt từ các nhóm có thu nhập cao sang các nhóm có thu nhập thấp (giả định hệ thống thuế ở đây là lũy tiến). Thứ hai, theo các hệ thống trả khi đến lượt hiện áp dụng ở hầu hết các nước phát triển thì

¹⁷Trong các dạng bảo hiểm xã hội không chính thức ở các nền kinh tế đang phát triển có cả các hình thức theo làng xã và gia đình, trong đó có thể có một hoặc nhiều dạng sau (Agarwal 1991; Drèze và Sen 1991; Platteau 1991): (1) đa dạng hoá nguồn thu nhập bằng di dân theo mùa vụ, buôn bán, trồng xen canh khi gia đình có đất, và chăn nuôi; (2) dựa vào các nguồn lực của xã, như đất, rừng, giúp cho các hộ sản xuất thêm và đa dạng hoá thu nhập (đây cũng là nguồn lương thực thay thế và bổ sung, được thảo, nhiên liệu, thức ăn chăn nuôi, nước, phân bón, gỗ, vải, v.v...); (3) sự hỗ trợ nhờ các mối quan hệ xã hội (người quen, họ hàng và bạn bè), và các mạng lưới tín dụng không chính thức; (4) dựa vào các cửa hàng của các hộ gia đình (lương thực thực phẩm, nhiên liệu, v.v...) và thay đổi cách tiêu dùng hiện có; và (5) các tổ chức "cơ sở" thường phát sinh từ các sáng kiến ở địa phương.

¹⁸Chẳng hạn như các mối quan hệ khách quen mất dần đi do thị trường lao động tạm thời và lao động di cư phát triển ở địa phương, do người lao động nghèo di cư đến các thành phố hoặc các vùng nông thôn khác, do hội nhập các thị trường hàng hoá trong nước, và do có thể mua ngoài thị trường các hàng hoá (chẳng hạn phân bón) thay cho các sản phẩm trước đây sản xuất tại địa phương (Agarwal 1991; Platteau 1991; Dasgupta 1993). Các mạng lưới dựa trên quan hệ họ hàng cũng mất đi do việc phân biệt tầng lớp và dịch chuyển giữa các vùng (Agarwal 1991, trang 198).

phải chi chuyển khoản giữa các thể hệ từ người đang lao động sang cho người cao tuổi vào thời điểm hiện tại.

Schmidt (1995) đã chứng minh rằng các hệ thống bảo hiểm xã hội chính thức ở nhiều nước đang phát triển tái phân phối thu nhập từ người nghèo sang người có thu nhập trung bình chứ không phải ngược lại. Đó là vì các chương trình này có nguồn tài chính dựa vào hệ thống thuế lũy thoái và vì thế các bộ phận dân số nghèo hơn phải chi trả các mức thuế suất cận biên cao hơn. Song vì các chương trình bảo hiểm xã hội thường mang tính chất lũy thoái nên đã ảnh hưởng xấu đến chính các chương trình này, vì đa phần dân số không biết và cũng không được hưởng lợi của các chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, các nước đang phát triển không thể dựa hoàn toàn vào các hệ thống có đóng góp do tình trạng nghèo ở các nước này, tỷ lệ trốn đóng góp cao và do các thị trường tài chính kém phát triển (nhất là các thị trường vốn và bảo hiểm). Việc thiết kế các hệ thống bảo hiểm xã hội mang tính chất lũy tiến có vai trò rất quan trọng ở các nước đang phát triển có nguồn tài chính khan hiếm. Với những nước như Việt Nam, điều này có nghĩa là cần phải thật chú ý đến cơ cấu của hệ thống trong đó có các mức đóng góp và trợ cấp và thiết lập các hệ thống giám sát hiệu quả để đảm việc chi trả chính xác và kịp thời các khoản đóng góp của cả chủ sử dụng lao động và người lao động. Chúng ta sẽ quay trở lại các vấn đề cần xem xét về thiết kế ở phần sau.

4. Đề xuất về thiết kế và thực hiện chương trình ở Việt Nam

Rõ ràng điểm khởi đầu để thiết kế chương trình ở Việt Nam là hệ thống các chương trình bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội chính thức hiện có và các thành phần trong mạng lưới an sinh xã hội hiện nay thuộc CTMTQG và các chính sách khác để hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương. Nếu xây dựng dựa trên cơ sở các thể chế và chính sách hiện có sẽ dễ hơn nhiều so với bắt đầu từ đầu, nhất là với các thể chế và chính sách đã biết rõ điểm mạnh và điểm yếu. Việc cần phải làm là xây dựng một chiến lược kết hợp các chương trình hiện có thành một khuôn khổ hợp nhất duy nhất để tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý hành chính, giảm bớt khoảng cách và trùng lặp trong phạm vi đối tượng tham gia, và giúp cho hệ thống mang tính tiến bộ hơn.

Các chương trình hiện nay đã bao quát được bốn mảng chính của một chương trình bảo hiểm xã hội hợp nhất:

- i. Các chương trình bảo hiểm xã hội hiện nay dành cho khu vực chính thức có thể ngay lập tức trở thành một phần trong hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia;
- ii. Các chương trình bảo hiểm y tế hiện nay có thể trở thành một phần trong hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia dù cần phải khắc phục các mặt yếu của các chương trình này;
- iii. Các hệ thống an sinh xã hội hiện có trong CTMTQG (nhất là các hình thức hỗ trợ đặc biệt cho các dân tộc thiểu số và các đối tượng dễ bị tổn thương) có thể kết hợp với quỹ cứu đói giáp hạt và quỹ hỗ trợ xã hội dành cứu trợ thường xuyên để hình thành cơ sở cho chiến lược trợ giúp xã hội quốc gia;
- iv. Các chương trình trợ giúp thương binh, cựu chiến binh và người có công với cách mạng (trong đó có các chế độ trợ cấp và các hình thức trợ giúp đặc biệt khác cho các nhóm đối tượng này) ở mức độ nào đó có thể trở thành một bộ phận trong các chương trình trợ cấp và trợ cấp mất sức lao động.

4.1. Thành phần hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất ở Việt Nam

Theo Atkinson (1989), bảo hiểm xã hội là một thuật ngữ có thể dùng để miêu tả hoặc một mục tiêu chính sách của chính phủ hoặc một tập hợp chính sách. Ở các nước công nghiệp, thuật ngữ bảo hiểm xã hội thường được hiểu theo nghĩa tập hợp chính sách, còn ở các nước đang phát triển thì các mục tiêu của các hệ thống bảo hiểm xã hội quan trọng hơn phương tiện nhằm đạt được mục tiêu. Cho đến nay, chính phủ vẫn chú trọng vào việc thiết kế và thực hiện các hệ thống chính sách. Tuy nhiên, các chính sách này vẫn không đáp ứng được mục tiêu về phạm vi đối tượng tham gia và tính bền vững. Có một phương pháp thực tế hơn để tiếp cận với bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là chú trọng vào các mục tiêu của hệ thống và sau đó xây dựng chính sách bảo hiểm, trợ giúp và cứu trợ cụ thể xoay quanh các mục tiêu này. Hai mục tiêu căn bản của hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất ở Việt Nam có thể là phải đạt được mức độ đối tượng tham gia sao cho bảo vệ được tất cả những người dễ bị tổn thương và có mức trợ cấp sao cho tạo được tác động đáng kể đối với cuộc sống của người hưởng trợ cấp. Dựa trên cơ sở các vấn đề đã trình bày trong các phần trên có thể thấy rõ được rằng hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất ở Việt Nam sẽ hoạt động ở ba cấp kinh tế và xã hội: đó là trong khu vực chính thức, khu vực không kê khai, và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác.¹⁹

4.1.1. Người lao động trong khu vực chính thức

Các đối tượng lao động này tham gia vào các chế độ bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội theo tiêu chuẩn dựa vào nguồn tài chính do cả chủ sử dụng lao động và người lao động đóng góp. Các đối tượng này cũng được hưởng bảo hiểm y tế, kể cả dạng bắt buộc và tự nguyện. Mức đóng góp hiện nay cho bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế có tính khả thi một khi cải thiện được tình hình thực hiện. Do cần sử dụng các nguồn lực công khan hiếm cho các lĩnh vực khác, chính phủ cần phải giảm dần mức tài chính công cấp cho các quỹ này và cuối cùng chuyển sang vai trò theo dõi giám sát. Từ kinh nghiệm ở Trung Quốc và Chile có thể rút ra được những bài học quý giá (xem Khung 2). Tuy nhiên, chính phủ cũng cần phải củng cố các hệ thống giám sát thật mạnh để đảm bảo cả công ty nhà nước và tư nhân tuân thủ đúng theo qui định.

¹⁹ Trong Phụ lục A có biểu đồ miêu tả hoạt động của các hợp phần bảo hiểm xã hội khác nhau ở Việt Nam.

Khung 2: Hai mô hình trợ cấp ở khu vực chính thức: Trung Quốc và Chile

A. Trung Quốc

Hệ thống trợ cấp ở Trung Quốc có từ năm 1951 và đã trải qua một số cuộc cải cách trong hai thập kỷ qua. Một trong những cuộc cải cách quan trọng nhất là vào năm 1986. Vào thời điểm này, chính phủ Trung Quốc đưa vào áp dụng khái niệm cá nhân đóng góp vào hệ thống trợ cấp. Chính phủ đã thành lập các cơ quan đặc biệt quản lý các quỹ trợ cấp độc lập với các chủ sử dụng lao động, và chủ sử dụng lao động không còn là bên đóng góp chủ yếu cho trợ cấp bảo hiểm xã hội nữa. Các cuộc cải cách này được thực hiện trên toàn quốc mặc dù ở mỗi tỉnh thành lại có những đặc điểm khác nhau. Một số tỉnh xây dựng các chương trình trợ cấp hoàn toàn dựa vào nguồn quỹ và các chương trình này thường mở rộng phạm vi đối tượng tham gia cho cả doanh nghiệp tư nhân và liên doanh. Trong năm 1991 theo một nghị quyết mới ban hành đã thiết lập một chế độ trợ cấp có ba bậc dành cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Đó là: (i) trợ cấp hưu trí cơ bản cho tất cả các đối tượng về hưu và nguồn tài chính là từ cả nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; (ii) chế độ bổ sung với nguồn tiền của doanh nghiệp lấy từ lãi kinh doanh; và (iii) tài khoản do cá nhân người lao động đóng góp trên cơ sở tự nguyện, và trở thành một khoản khi về hưu. Theo chính sách này, các doanh nghiệp không còn chịu trách nhiệm duy nhất về trợ cấp và trách nhiệm đối với các quỹ tập thể mới được chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân người lao động. Một số tỉnh thành bắt đầu thử nghiệm phương pháp hai bậc do chủ sử dụng lao động và người lao động đóng góp và không có dạng trợ cấp cơ bản đảm bảo do chính phủ hỗ trợ. Phương pháp này đặc biệt phổ biến đối với đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân và liên doanh, trong bảng lương của những doanh nghiệp này số lượng người về hưu thường rất ít. Trong năm 1997, chính phủ đã ban hành nghị định qui định rằng việc thiết kế chế độ trợ cấp phải là trách nhiệm của chính phủ chứ không phải là trách nhiệm của doanh nghiệp. Sau đó, chính phủ đã thành lập một hệ thống bảo hiểm trợ cấp cơ bản thống nhất trên toàn quốc thay thế tất cả các chương trình thí điểm được thực hiện cho đến cuối thế kỷ. Trợ cấp ở các khu vực thành thị hiện đã đến được với 90% tổng số người đang lao động trong diện tham gia bắt buộc. Vào đầu những năm 1990, thì tỷ lệ này chỉ khoảng 45% lực lượng lao động ở thành thị. Trợ cấp tuổi già cơ bản gồm hai phần: kế hoạch đóng góp theo mức xác định ước tính có lập tài khoản cá nhân cho từng người lao động; và một kế hoạch trợ cấp theo mức xác định được gọi là “trợ cấp xã hội” dựa trên cơ sở tài khoản đóng góp của xã hội. Các khoản đóng góp này tùy thuộc vào địa điểm (thành phố, quận huyện hoặc tỉnh) hoặc tùy thuộc vào ngành (hàng không, đường sắt). Mức đóng góp hiện nay của người lao động vào tài khoản cá nhân đã tăng lên đến 8%. Mức đóng góp tối đa của doanh nghiệp qui định ở mức 20% tổng bảng lương, song trên thực tế khác nhau khá nhiều trong phạm vi từ 15 đến 30%. Tuổi về hưu đối với nam giới là 60 và nữ giới là 55 đối với làm công ăn lương và 50 đối với nữ công nhân. Những người làm việc ở các ngành được coi là nguy hiểm có thể về hưu sớm hơn 5 năm; các cán bộ chuyên môn cao cấp có thể về hưu muộn 5 năm. Khoảng thời gian liên tục công tác để đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo đề xuất tối thiểu là 15 năm, mặc dù trên thực tế có thể thay đổi. Nam giới đến 50 tuổi được phép về hưu sớm và nữ giới là 45 tuổi áp dụng với những người đã đóng góp 10 năm và mất sức lao động. Các chế độ này hiện chỉ áp dụng trong phạm vi các khu vực thành thị. Chính phủ cũng đã cố gắng mở rộng phạm vi đối tượng tham gia bằng cách áp dụng các hình thức trợ cấp dành cho người dân sống ở các vùng nông thôn, có tên gọi là ‘Kế hoạch Cơ bản về Bảo hiểm Xã hội Tuổi già ở Nông thôn’.

Nguồn: Whiteford (2003).

B. Chile

Chile đã áp dụng trợ cấp bảo hiểm xã hội tư nhân hoàn toàn dựa vào nguồn quỹ vào năm 1981. Hệ thống này thay cho hệ thống trả khi đến lượt áp dụng trước đó và là một trong những hệ thống hoàn toàn dựa vào nguồn quỹ đầu tiên được đưa vào áp dụng ở các nước đang phát triển. Hệ thống này thuộc dạng tham gia bắt buộc và dựa vào kế hoạch tiết kiệm tư nhân bắt buộc. Người lao động phải đóng góp 10% thu nhập hàng tháng trong toàn bộ thời gian lao động của mình vào một tài khoản cá nhân. Trong tổng số tiết kiệm này trừ đi một khoản phí hành chính cố định. Ngoài ra, người lao động đóng một khoản để chi trả bảo hiểm tài chính và mất sức lao động. Toàn bộ trợ cấp được gọi theo thuật ngữ là ‘*unidades de fomento*’, một đơn vị tiền tệ được tính hệ số hàng tháng theo lạm phát. Làm như vậy để đảm bảo mức trợ cấp trong tình hình lạm phát vốn phổ biến ở châu Mỹ Latinh. Giá trị cuối cùng của trợ cấp phụ thuộc vào: (i) số tiền tích lũy trong tài khoản cá nhân; (ii) lãi tích lũy trong tài khoản; và (iii) tuổi thọ. Người lao động trước đó đã đóng góp cho chế độ trợ cấp trả khi đến lượt được nhận “giấy chứng nhận” của chính phủ tương ứng với số tiền mà họ đã đóng góp trong đời cho hệ thống cũ. Khi về hưu (nam giới là 65 tuổi và nữ là 60), người lao động có thể lựa chọn nhận trợ cấp hàng năm từ một công ty bảo hiểm nào đó hoặc trợ cấp hưu trí như đã định trong chương trình hoặc kết hợp cả hai. Các trợ cấp mất sức lao động và tuất được chi trả qua các công ty bảo hiểm tư nhân. Trong hệ thống này, các công ty quản lý quỹ tư nhân quản lý về mặt hành chính các quỹ trợ cấp. Các công ty này chỉ được phép thực hiện chức năng này và không được tham gia vào bất kỳ loại dịch vụ tài chính nào khác. Hệ thống trợ cấp do chính phủ qui định nghiêm ngặt thông qua Cơ quan Giám sát Quản lý Quỹ Trợ cấp. Nhà nước cũng có các hình thức đảm bảo thêm. Cụ thể là nhà nước sẽ phát trợ cấp tối thiểu cho tất cả người lao động có bảo hiểm đã làm việc tối thiểu là 20 năm. Tuy nhiên, số tiền này không được tính hệ số theo lạm phát. Hệ thống này đã giải quyết thành công những bất cân đối do các yếu tố về dân số và chính trị, như dân số già đi và xu hướng các chính phủ dân túy ở châu Mỹ La tinh chi tiêu công hoặc hứa hẹn quá nhiều trước dịp bầu cử. Hệ thống này cũng bảo vệ các quỹ trợ cấp tránh ảnh hưởng của các chu kỳ tài chính và chính trị và có ảnh hưởng tích cực đến mức tiết kiệm và tích lũy vốn ở Chile. Chương trình trợ cấp cũng tác động đáng kể đến quá trình phát triển các thị trường tài chính và vốn ở Chile, và do đó có tác động đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên tình hình kinh tế ở Chile vào đầu những năm 1980 rất khác so với tình hình ở Việt Nam hiện nay. Nhất là mức GDP tính theo đầu người cao hơn nhiều, và tỷ lệ lực lượng lao động tham gia vào khu vực chính thức cũng cao hơn. Song vì nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển nên mô hình của Chile rất có thể là một phương án lựa chọn đúng đắn được trong dài hạn.

Nguồn: Arenas de Mesa và Bertrandou (1997).

4.1.2. Người lao động tự do và trong khu vực không kê khai

Đưa bảo hiểm xã hội đến với người lao động tự do và người lao động trong khu vực không kê khai là thách thức lớn nhất Việt Nam phải giải quyết trong quá trình phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Theo các tài liệu về bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển, có một số chiến lược có thể áp dụng để mở rộng phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng này. Có một giải pháp là trực tiếp mở rộng các dạng bảo hiểm xã hội chính thức hiện nay cho các nhóm đối tượng chưa tham gia mà không cần phải sửa đổi bổ sung nhiều. Mặc dù giải pháp này có ưu điểm là phát triển dựa trên khung thể chế và hành chính hiện có, song chi phí của các chương trình sẽ rất cao vì các đối tượng này vẫn chiếm một tỷ lệ cao trong lực lượng lao động.

Như đã nói ở trên, việc mở rộng ngay lập tức các dạng bảo hiểm xã hội toàn bộ theo kiểu phương Tây vào thời điểm này là không khả thi về mặt tài chính. Có một giải pháp khác là tái cơ cấu hoặc điều chỉnh các chế độ hiện nay để mở rộng phạm vi tham gia cho các nhóm đối tượng chưa được bảo hiểm. CTMTQG và các chương trình mục tiêu khác áp dụng chiến lược này. Mặc dù các chương trình này đã vươn tới được nhiều đối tượng trước đây chưa được hưởng các dạng bảo hiểm xã hội khác, song mức độ thực hiện đối với các nhóm đối tượng thích hợp vẫn còn kém và mức trợ cấp quá thấp nên không tạo được ảnh hưởng đáng kể đến mức sống của họ. Theo như đánh giá của UNDP-Bộ LĐ-TBXH (2004) thì sự phụ thuộc vào xác minh tiềm lực tài chính đã có tác động tiêu cực đối với phạm vi bao quát của chương trình.

Với điểm này đưa đến giải pháp có thể thực hiện thứ ba: đó là đưa vào áp dụng các chế độ không yêu cầu đóng góp mà dựa vào hệ thống thuế chung. Mức trợ cấp theo các chương trình tương tự ở các nước đang phát triển khác nói chung cũng ít nên không khuyến khích các nhóm khá giả hơn tham gia song cũng đủ để trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Các chương trình này nói chung mang tính chất lũy tiến và có thành phần tái phân phối lớn vì các chương trình này phụ thuộc vào khả năng của chính phủ chuyển khoản các nguồn lực từ các nhóm khá giả hơn sang các nhóm có thu nhập thấp. Các chương trình này thực sự kết hợp có kết quả cả cách tiếp cận hưởng vào đối tượng ưu tiên và cách tiếp cận thực hiện toàn dân (Besley và Kanbur 1993). Các chương trình này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong phần dưới.²⁰ Một điều kiện tiên quyết để thực hiện chiến lược này là phải tăng cường hệ thống thuế và thu thuế. Các chính sách này cần đưa ra hình thức bảo trợ cơ bản cho các nhóm đối tượng hiện chưa được hưởng bất kỳ hình thức bảo hiểm xã hội nào. Đồng thời, các chính sách này cũng cho phép Việt Nam dần củng cố năng lực tài chính của hệ thống trong quá trình phát triển kinh tế. Cuối cùng là chính phủ có thể xem xét việc chuyển sang một hệ thống có đóng góp trên toàn quốc và được bổ sung thêm bằng chi chuyển khoản trợ giúp xã hội cho các nhóm cụ thể dễ bị tổn thương.

4.1.3. Các nhóm dễ bị tổn thương không thuộc hai nhóm trên

Những đối tượng này sẽ được trợ giúp bằng cách kết hợp chi chuyển khoản trợ giúp xã hội dựa vào ngân sách nhà nước trung ương (tức là từ hệ thống thuế). Các chương trình phù hợp nhất sẽ xây dựng dựa trên CTMTQG hiện nay và các chương trình mạng lưới an sinh khác hiện có ở Việt Nam. Trong các chương trình này có bao gồm trợ cấp theo CTMTQG cho các đối tượng dưới ngưỡng nghèo, trong đó có các chính sách đặc biệt dành cho các đối tượng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương (trong đó có người bị mất sức lao động, người già, các bà mẹ độc thân và trẻ mồ côi), quỹ cứu đói giáp hạt và quỹ hỗ trợ xã hội dành cứu trợ thường xuyên. Quỹ cứu đói giáp hạt trong điều kiện hiện nay là một quỹ cứu trợ với tên gọi kết hợp là quỹ dự phòng cứu đói giáp hạt và cứu trợ thiên tai. Theo đề xuất của ILO (1999a) nên tách riêng hai quỹ này. Vì các hoạt động sản xuất nông nghiệp của Việt Nam mang tính chất mùa vụ, nên quỹ cứu đói giáp hạt cần trở thành một hệ thống trợ giúp thường xuyên cho các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể. Một nhóm nữa cũng quan trọng là các hộ gia đình không có đất ở nông thôn.

Ngược lại, quỹ cứu trợ thiên tai chỉ cần hoạt động khi có thiên tai xảy ra. Ngược với cách làm thông thường hiện nay (Bộ LĐ-TBXH-UNDP 2004), các khoản chi từ quỹ này chỉ cần thực hiện khi xác định có thiên tai xảy ra và không nên sử dụng quỹ này vào bất cứ mục đích nào khác. Cũng nên phân cấp ra quyết định cho cấp tỉnh về sử dụng những quỹ này.

²⁰ Xem Mục 4.2.

4.2. Thách thức phía trước

Trước mắt cần phải quan tâm chú ý đến một số vấn đề khi chính phủ tiến tới áp dụng một phương pháp tiếp cận hợp nhất đối với bảo hiểm xã hội. Đó chính là các vấn đề về phạm vi và đối tượng tham gia chương trình, khả năng tài chính, năng lực thể chế và hành chính, và thời điểm. Trong phần còn lại của mục này, chúng ta sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề này.

4.2.1. Phạm vi và đối tượng tham gia chương trình

Nếu chỉ mở rộng phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay từ khu vực chính thức cho cả người lao động trong khu vực không kê khai nói chung không phải là một giải pháp thực tiễn ở các nước đang phát triển. Việc mở rộng bảo hiểm xã hội cần liên quan trực tiếp với nhu cầu trước mắt của những người sẽ được đưa vào tham gia bảo hiểm. Cũng cần phải cân nhắc các hạn chế về thể chế và ngân sách. Bước đầu tiên trong bất kỳ quá trình mở rộng phạm vi đối tượng tham gia nào cũng là xem xét cụ thể các đặc điểm của các nhóm dân cư chưa được tham gia bảo hiểm và nhu cầu của họ. Một điều kiện tiên quyết cơ bản để thiết kế hệ thống là phân tích tỉ mỉ chi phí-lợi ích, trong đó có tính đến các chi phí xã hội và kinh tế như đã trình bày ở trên.

Một chương trình quốc gia hợp nhất ở Việt Nam cũng có nghĩa là mở rộng phạm vi đối tượng tham gia của các chương trình hiện nay cho:

- i. Các đối tượng nhẽ ra có bảo hiểm theo các chế độ hiện nay nhưng thực tế lại chưa; và,
- ii. Các cá nhân và các hộ gia đình hiện chưa tham gia các chương trình hiện nay.

Có ba nhóm quan trọng thuộc về diện thứ hai: người lao động trong khu vực chưa kê khai, dân di cư từ nông thôn ra thành thị và giữa các vùng nông thôn, và dân tộc thiểu số.

Khu vực không kê khai

Người lao động trong khu vực không kê khai (kể cả nông dân) không nằm trong phạm vi bao quát của các hệ thống bảo hiểm xã hội hiện nay. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào ĐTMSGĐVN năm 2002, có 30% dân số ở độ tuổi từ 15 trở lên có làm công ăn lương ít nhất vào một thời điểm nào đó. Đây có thể là số liệu ước tính tổng thể thấp hơn thực trạng làm công ăn lương phổ biến hiện nay vì trong các cuộc điều tra hộ gia đình thường có xu hướng khai thấp đi đối với việc làm tự tìm. Có tỷ lệ phần trăm khá cao lực lượng lao động coi lao động nông nghiệp (47%) hoặc lao động trong kinh doanh hộ gia đình (23%) là nguồn việc làm chính (Ngân hàng Thế giới 2002). Như đã trình bày ở trên, tỷ lệ người lao động khai có làm công ăn lương đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

CTMTQG đến được với một số nhóm có thu nhập rất thấp, song còn nhiều hộ khác vẫn có khả năng dễ bị tổn thương trước các rủi ro xã hội và kinh tế trong khi họ có rất ít tài sản giúp họ vượt qua được các cơn sốc.²¹ Thiếu việc làm là một vấn đề nghiêm trọng đối với người lao động trong khu vực không kê khai, nhất là các vùng nông thôn. Ốm đau và thương tật cũng là những vấn đề quan trọng đối với các nhóm đối tượng này. Hiện nay, chỉ có những doanh nghiệp nào có trên 10 lao động mới đóng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam. Có một giải pháp là giảm ngưỡng này xuống 5 lao động (như ở Ấn Độ). Một giải pháp khác là thiết kế các chương trình nghề nghiệp cho các đối tượng lao động dễ bị tổn thương (xem Mục 3). Hoặc áp dụng các chế độ không yêu cầu đóng góp cũng có thể là một dạng bảo trợ (xem Mục 4.2.2 dưới đây).

Khung 3: Bảo hiểm xã hội cho khu vực không kê khai ở Nam Ấn Độ

Bang Kerala miền Nam Ấn Độ là nơi có một trong những hệ thống bảo hiểm xã hội có hiệu quả nhất ở các nước đang phát triển. Một đặc điểm quan trọng trong mô hình phát triển của Kerala là có bao quát cả đối tượng lao động trong khu vực không kê khai hoặc không có tổ chức. Trong chương trình này có sử dụng các quỹ phúc lợi và do các hội đồng phúc lợi ba bên theo qui định của luật quản lý. Ví dụ trong số này có Quỹ Phúc lợi Lao động Kerala chung (dành cho các cán bộ công chức của chính phủ có lương thấp, lao động tự do như thợ thủ công, và lao động nông thôn có tay nghề và không có tay nghề), và các quỹ phúc lợi cụ thể cho người lao động ngành sản xuất rượu toddi, lao động bốc vác, vận tải ô tô, ngành xơ dừa, hạt điều, dệt vải thủ công, sợi thủ công, xây dựng, ngành sản xuất rượu mạnh, và ngành nông nghiệp. Người lao động ngành bốc vác theo truyền thống là

²¹ Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới dựa vào ĐTMSGĐVN năm 2002, 10,2% hộ gia đình Việt Nam không có tài sản (Ngân hàng Thế giới 2002).

các nhóm hoạt động xã hội và chính trị tích cực nhất ở Kerala và nghiệp đoàn của ngành này là một trong những nghiệp đoàn có ảnh hưởng chính trị mạnh nhất ở Ấn Độ dù công việc này có tính chất tạm thời (xem Heller 1996). Tổng cộng ở Kerala có trên 25 chương trình bảo hiểm và trợ cấp xã hội. Trong số đó, những chương trình có tác động lớn nhất xét về phân bổ ngân sách và phạm vi đối tượng tham gia là trợ cấp cho lao động nông nghiệp, trợ cấp người bán hàng và quả phụ, và trợ cấp mất sức lao động (Chính quyền Kerala 1997c). Không phải lúc nào khu vực không có tổ chức cũng đồng nghĩa với không có qui chế. Tại Kerala, người lao động trong khu vực theo truyền thống không có tổ chức đã dành được sức mạnh chính trị thông qua các nghiệp đoàn của mình và đã gây được ảnh hưởng với các chính sách của chính quyền có liên quan đến bảo hiểm xã hội và các quyền tối thiểu về việc làm, lương, an toàn lao động và thậm chí lao động trẻ em. Vì thế Kerala là một ví dụ hay về tầm quan trọng của người dân tham gia vào quá trình phát triển. Ngày nay, Kerala là một trong những nơi có tỷ lệ người dân biết chữ nhiều nhất ở Ấn Độ. Chăm sóc sức khỏe được cải thiện đã làm giảm đáng kể mức tử vong. Các chương trình bảo hiểm xã hội đã đến được hầu hết người dân, kể cả những người trong khu vực không có tổ chức.

Di dân từ nông thôn ra thành thị và giữa các vùng nông thôn

Tốc độ thay đổi kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam trong thập kỷ qua đã làm cho số lượng người và hộ gia đình từ nông thôn ra thành thị tăng. Hiện vẫn áp dụng hệ thống hộ khẩu (residential permit) nghiêm ngặt để kiểm soát mức độ dịch chuyển. Khả năng tiếp cận trợ cấp xã hội và các dịch vụ xã hội thường phụ thuộc vào diện cư trú. Trong số những người chuyển đến các khu vực thành thị có nhiều người cư trú bất hợp pháp, do vậy không có hộ khẩu và không tiếp cận được với bảo hiểm xã hội. Các tỉnh thường miễn cưỡng tái phân loại diện cư trú vì lượng phân bổ từ chính phủ trung ương cho các tỉnh thường gắn liền với qui mô dân số. Hiện cần có thêm thông tin về các hộ gia đình và cá nhân hay dịch chuyển, điều kiện sống của họ, cách kiếm sống vì họ không nằm trong các cuộc điều tra hiện có. Hiện cực kỳ thiếu thông tin về tình trạng di dân giữa các vùng nông thôn dù với tình hình làm công ăn lương trong nông nghiệp tăng lên nhanh chóng có thể đoán được số người thuộc diện này đã tăng lên.

Chiến lược hạn chế người dân di chuyển hiện nay không chỉ khó thực thi mà còn phản tác dụng. Trên thực tế, chính phủ kỳ vọng tỷ lệ phần trăm dân số ở các khu vực thành thị trên toàn quốc sẽ ở mức trên 40% trong trung hạn. Cần chuẩn bị từ bây giờ để giải quyết vấn đề an ninh kinh tế khi người dân nông thôn đổ vào các thành phố như dự kiến. Việt Nam sẽ có lợi khi áp dụng một hệ thống đăng ký nhân khẩu ít mang tính chất hạn chế hơn để tạo điều kiện thị trường lao động đủ linh hoạt, chẳng hạn như đưa vào áp dụng sổ bảo hiểm xã hội trên toàn quốc để đối chiếu được đối tượng hưởng lợi thay vì dựa vào hộ khẩu như hiện nay (xem Khung 4)

Khung 4: Dân ngoại tỉnh ở thành thị Trung Quốc

Cũng như ở Việt Nam, chính phủ Trung Quốc sử dụng hộ khẩu để qui định điều kiện trợ cấp bảo hiểm xã hội và kiểm soát dịch chuyển trong dân và lượng cung lao động. Có hai vấn đề nảy sinh (Ngân hàng Thế giới 2002). Thứ nhất là khả năng tiếp cận trợ cấp xã hội của dân ngoại tỉnh ở các khu vực thành thị bị hạn chế vì họ không thể chính thức xin được việc làm nếu không có hộ khẩu. Thứ hai là nhiều lao động nông thôn vẫn ở lại vùng nông thôn, dẫn đến tình trạng vượt cung về lao động, làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn. Để cố gắng giải quyết những vấn đề này, chính phủ Trung Quốc gần đây đã tuyên bố dự định xóa bỏ nhiều phần trong hệ thống hộ khẩu để tăng độ linh hoạt trên thị trường lao động. Có một giải pháp là cấp sổ bảo hiểm xã hội quốc gia không gắn liền với diện cư trú. Hệ thống này cũng tương tự như các hệ thống đang áp dụng ở các nước công nghiệp. Những thay đổi này cần thực hiện dần dần và có tính đến các vấn đề hiện đang phải đối mặt ở các thành phố rất lớn trong khi ở các nước công nghiệp lại không có.

Các dân tộc thiểu số

Theo hầu hết các chỉ số kinh tế và xã hội, nói chung các dân tộc thiểu số không khá bằng dân tộc Kinh. Trong năm 2002, 69,3% các hộ dân tộc thiểu số sống dưới ngưỡng nghèo quốc gia trong khi đó người Kinh và người gốc Hoa chỉ có 23,1% (xem Bảng 1). Ngoài ra, 34,3% trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi ở các tỉnh miền Núi phía Bắc và 45,3% ở các vùng Miền Trung và Tây Nguyên có tỷ lệ nhẹ cân so với tuổi trong khi tỷ lệ này trên toàn quốc là 25,7% và của các hộ người Kinh hoặc người Hoa là 23,2% (Ngân hàng Thế giới 2002). Tỷ lệ phần trăm dân tộc thiểu số trong số nghèo cũng tăng lên từ 20% trong năm 1993 lên đến trên 30% trong năm 2002 (Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2004).²²

²² Xem thêm DFID-UNDP (2003).

Chính phủ đã có các chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các dân tộc thiểu số trong phạm vi CTMTQG. Chương trình này đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong việc xác định đối tượng và phạm vi hưởng lợi (UNDP-Bộ LĐ-TBXH 2004). Với mức nghèo của các nhóm đối tượng này, trong thời gian tới đây không thể nào hầu hết các hộ gia đình dân tộc thiểu số lại có thể chuyển sang tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội có đóng góp. Các khoản chi chuyển khoản trợ giúp xã hội, dù bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật, sẽ đóng vai trò căn bản đảm bảo giúp các dân tộc thiểu số đối phó với rủi ro về kinh tế-xã hội hiện nay và trong tương lai. Chính phủ cũng có thể hành động ngay trong một lĩnh vực nữa là tăng số hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dạng trợ cấp bằng cách thông tin về các chương trình này phổ biến hơn và dễ tiếp cận hơn (xem Mục 4.4.3 ở dưới). Các hệ thống không yêu cầu đóng góp cũng tạo điều kiện tiếp cận với các dạng trợ cấp trong khi giảm được chi phí hành chính và xác định sai đối tượng.

4.2.2. Xác định ưu tiên chương trình

Chính phủ phải xác định thứ tự ưu tiên để sử dụng tốt nhất nguồn lực công hạn chế. Đối với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như đã nói ở trên, những rủi ro như bệnh tật và kinh tế không vững lúc tuổi già là những vấn đề cần phải quan tâm chú ý ngay. Sức khỏe và tuổi già là những nguyên do hàng đầu gây nghèo ở các hộ gia đình Việt Nam (Ngân hàng Thế giới 2002; Justino và Litchfield 2003; Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004).

Bảo hiểm y tế

Chi phí y tế và mất việc làm ngoài dự kiến do bệnh tật gắn liền với nghèo ở Việt Nam cũng như ở nhiều nơi khác. Chính phủ đã áp dụng các biện pháp bảo hiểm y tế như thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và các dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa và thẻ khám chữa bệnh miễn phí.²³ Mặc dù vào đầu những năm 1990 đã bắt đầu áp dụng phí khám chữa bệnh, song có một số nhóm đối tượng nhất định như người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân lao hoặc bệnh phong, và người nghèo được miễn phí. Theo báo cáo đánh giá về CTMTQG và Chương trình 135 của UNDP-Bộ LĐ-TBXH (2004), các chương trình này không đến được với tất cả người nghèo, và tỷ lệ hoàn trả cho các bên chăm sóc sức khỏe thường quá thấp, nên không khuyến khích các bên cung cấp dịch vụ cho người nghèo (Sepehri 2005). Cần nghiên cứu thêm về mức miễn giảm và nên miễn giảm chi phí nào (ví dụ khám bệnh, thuốc, xét nghiệm) (Ngân hàng Thế giới 2002). Ngoài ra, theo các ước tính gần đây, người nghèo có xu hướng khai ít bệnh hơn so với các nhóm khá giả hơn, song những bệnh họ khai lại thường nặng hơn (Bảng 5).²⁴ Người nghèo cũng ít sử dụng các dịch vụ y tế hiện có hơn các nhóm khá giả hơn (Bảng 5). Chi tiêu cá nhân cho chăm sóc sức khỏe của người nghèo cũng thấp hơn so với người giàu (Bảng 6). Tuy nhiên, chi phí dành cho y tế của các hộ nghèo lại chiếm tỷ lệ cao hơn trong chi tiêu ngoài lương thực thực phẩm so với các nhóm thu nhập cao hơn (Sepehri 2005).

Bảng 5: Kết quả về sức khỏe của một số nhóm ngũ phân vị

	Nhóm ngũ phân vị thứ nhất (nghèo nhất)	Nhóm ngũ phân vị thứ hai (nghèo)	Nhóm ngũ phân vị thứ năm (giàu nhất)	Việt Nam
Tỷ lệ người bị ốm trong 12 tháng qua	33,5	40,4	34,3	37,4
Tỷ lệ người bị ốm không làm việc được	13,4	13,3	6,7	10,9
Tỷ lệ phần trăm người sử dụng các dịch vụ y tế hoặc tự điều trị	34,4	43,1	37,4	39,8
Số lần sử dụng dịch vụ y tế trung bình một năm	8,3	11,6	10,4	10,8

Nguồn: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004, dựa vào các số liệu ước tính của ĐTMŞHGDVN năm 2002.

²³ Chính phủ cũng đã thực hiện các chương trình quốc gia khác về y tế như các chương trình nước và vệ sinh nông thôn, các chương trình phòng chống lao, sốt rét và các chương trình dinh dưỡng để xoá bỏ tình trạng suy dinh dưỡng.

²⁴ hực tế vẫn biết rằng người nghèo thường khai thời gian bị bệnh ít hơn so với người giàu. Đó là do cách hiểu khác nhau thế nào là ốm đau. Người nghèo cũng nghĩ việc để nghỉ ngơi khi ốm không nặng ít hơn so với người giàu.

Bảng 6: Chi tiêu cá nhân cho y tế năm 2002 theo nhóm ngũ phân vị tiêu dùng

	Tỷ lệ phần trăm đi khám chữa theo chuyên môn	Nghìn đồng/năm					Tỷ lệ phần trăm trong chi tiêu của hộ	
		Điều trị	Thuốc	Dụng cụ y tế	Đóng góp	Bảo hiểm y tế		Tổng cộng
Nhóm 1	46,3	151,6	137,1	3,3	2,4	4,5	298,8	4,31
Nhóm 2	48,4	254,4	187,1	5,5	2,3	7,4	456,7	5,02
Nhóm 3	48,8	365,9	213,0	6,2	2,0	10,9	598,1	5,28
Nhóm 4	52,6	553,9	262,9	8,6	1,9	16,8	844,0	5,78
Nhóm 5	56,3	1110,4	449,8	21,4	1,4	31,1	1614,1	5,77
Việt Nam	50,6	520,6	260,6	9,6	2,0	15,1	807,9	5,29

Nguồn: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004, dựa vào số liệu của ĐTMHGDVN 2002.

Chú thích: Chi tiêu cá nhân cho y tế được tính trên một người bệnh có đi khám chữa hoặc mua thuốc.

Trong năm 2000 một chính sách mới đã được áp dụng để tăng bảo hiểm y tế bằng cách mở rộng phạm vi tham gia bảo hiểm y tế thông qua Bảo hiểm Y tế Việt Nam (BHYTVN). Trong chính sách này qui định kết hợp tiết kiệm bắt buộc đối với người lao động có việc làm chính thức, tiết kiệm tự nguyện bằng việc mua thẻ y tế và cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí của BHYTVN cho người nghèo. Sau 5 năm thực hiện đã thấy rõ những thiếu sót của phương pháp này. Thứ nhất, hệ thống này chỉ bao quát được khoảng 14% dân số dưới ngưỡng nghèo của TCTK và 36% số người dưới ngưỡng nghèo lương thực của TCTK (Ngân hàng Thế giới 2002). Thứ hai, khả năng tiếp cận các dịch vụ thường bị hạn chế.²⁵ Thứ ba, người có thẻ khám chữa bệnh thường phải trả các khoản phí chính thức và không chính thức cho bên cung cấp dịch vụ. Hiện rất cần đánh giá lại các chính sách y tế ở Việt Nam nhằm đảm bảo người nghèo được chăm sóc sức khỏe. Khi đánh giá lại như vậy cần so sánh phương pháp tiếp cận của Việt Nam hiện nay với các chiến lược khác nhau áp dụng ở các nước khác trong khu vực và ở các nơi khác. Chẳng hạn, Trung Quốc đã áp dụng một chương trình dựa trên đóng góp của các chủ sử dụng lao động và người lao động. Hệ thống này cũng đã mở rộng được phạm vi tham gia mà không tạo gánh nặng không thích đáng cho ngân sách nhà nước (Xem Khung 5). Việt Nam có thể rút ra được kinh nghiệm có ích khi xem xét cẩn thận ví dụ này và các phương án khác để xác định các cơ chế thực hiện chăm sóc sức khỏe cơ bản có thể thực thi được cho toàn dân Việt Nam dù họ là ai, ở đâu và thu nhập như thế nào.

Khung 5: Bảo hiểm y tế ở Trung Quốc

Trung Quốc khá thành công trong việc mở rộng phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở các khu vực thành thị bằng cách sử dụng kết hợp tài khoản tiết kiệm cá nhân và quỹ đóng góp của các chủ sử dụng lao động. Trong thiết kế bảo hiểm y tế có xác định rõ giới hạn chi trả từ từng quỹ. Do vậy, các khoản phí bảo hiểm dạng trả khi đến lượt cho các quỹ bảo hiểm y tế theo qui định của pháp luật ở các khu vực thành thị hiện chiếm khoảng 8-9% tổng lương (Ngân hàng Thế giới 2002). Chính phủ cũng đã khởi xướng các chương trình thí điểm để tìm cách làm cho các quỹ này có kết quả hơn. Đã áp dụng một hệ thống mới tại hai thành phố ở Trung Quốc, theo hệ thống này, người lao động đóng một nửa phần đóng góp của mình vào các tài khoản tiết kiệm cá nhân, còn chủ sử dụng đóng một nửa còn lại vào một quỹ đóng góp. Khi người lao động bị ốm, chi phí y tế trước tiên chi từ tài khoản cá nhân và từ tiết kiệm cá nhân. Tuy nhiên, nếu chi phí trong năm nào đó vượt quá số tiền trong tài khoản cá nhân cộng thêm 5% tổng lương của người lao động đó, phần vượt trội sẽ chi trả từ quỹ đóng góp của chủ sử dụng lao động. Nếu chi phí y tế gấp 5 lần lương cả năm của người lao động đó, chi phí này sẽ được chi trả dựa vào một chính sách bảo hiểm y tế bổ sung (Ngân hàng Thế giới 2002). Đây là một hệ thống rất phức tạp song đã làm tăng được hiệu quả sử dụng nguồn lực khan hiếm dành cho y tế.

²⁵ Xem thêm UNDP-Bộ LĐ-TBXH (2004).

Bảo hiểm tuổi già

Trong những năm gần đây Việt Nam có nhiều thay đổi đáng kể về mặt nhân khẩu. Tổng tỷ suất sinh (tức là số con bình quân của một phụ nữ trong đời) đã giảm từ gần 5 trong năm 1979 xuống còn 2,3 năm 1999 (Tổng Điều tra Dân số năm 1999). Do vậy, tỷ lệ người ở độ tuổi 60 trở lên trên 1000 dân so với độ tuổi 15-59 dự kiến sẽ tăng từ 14% trong năm 1999 lên 17% trong năm 2024 (Bộ Y tế 2000). Cần phải có các chính sách trợ giúp bảo hiểm kinh tế cho người cao tuổi ngay từ bây giờ khi người nhiều tuổi vẫn còn chiếm tỷ lệ tương đối thấp trong dân số. Cần kiểm tra và xây dựng các phương án chính sách để thiết kế các công cụ và chương trình phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.²⁶

Người nhiều tuổi dễ bị tổn thương không theo tỷ lệ nhất định khi có thay đổi về kinh tế và xã hội, nhất là đối với những người và hộ gia đình không có tiết kiệm hoặc tài sản khác và không thể dựa vào con cháu. Gorman (2004) đề xuất cách giải quyết vấn đề bảo hiểm tuổi già ở các nước đang phát triển bằng cách thực hiện các chương trình trợ cấp (trợ cấp xã hội) không yêu cầu đóng góp.²⁷ Một trong những ưu điểm chính của trợ cấp xã hội so với trợ cấp dựa vào xác minh tiềm lực tài chính (dành cho đối tượng nghèo) là trợ cấp dựa vào xác minh tiềm lực tài chính có chi phí hành chính cao làm giảm nguồn lực dành cho các đối tượng hưởng trợ cấp mà lại không nhất thiết đến với tất cả người nghèo. Có một số nước đang phát triển đã áp dụng các hệ thống trợ cấp xã hội trên qui mô lớn, như Antigua, Acentina, Banglădet, Bôlivia, Bôtxoana, Braxin, Chilê, Côxta Rica, Dominica, Ấn Độ, Mauritus, Mêhicô, Namibia, Nêpan, Nam Phi, Xênegan, và Uruguay.

Thực tế ở các nước đã áp dụng trợ cấp xã hội không yêu cầu đóng góp cho thấy trợ cấp xã hội hướng hỗ trợ phát triển cho các hộ nghèo nhất, phục hồi nền kinh tế địa phương, và tái phân phối của cải cho các hộ có thu nhập thấp. Trợ cấp xã hội gắn với cải thiện tình hình dinh dưỡng ở trẻ em, làm tăng tỷ lệ đến trường, và cải thiện sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nhất là trẻ em được hưởng lợi của trợ cấp xã hội vì ông bà có xu hướng đầu tư vào lương thực thực phẩm, quần áo, học hành và chăm sóc sức khỏe cho các cháu của mình (như ở Bôlivia, Namibia, Nam Phi, Zambia và Braxin). Trợ cấp xã hội cũng đã chứng tỏ khuyến khích được người dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ. Trợ cấp xã hội có tính chất trung lập về giới nên có thể góp phần làm giảm khoảng cách về giới (Gorman 2004).

Dù trợ cấp xã hội không nhất thiết phải là những khoản lớn song cũng là một nguồn cứu cánh quan trọng đối với người nghèo. Trợ cấp xã hội cũng làm giảm nghèo trong hộ gia đình vì góp thêm vào thu nhập của gia đình (ở các nước đang phát triển thường là như vậy). Thu nhập từ trợ cấp làm khác biệt hẳn cuộc sống của các hộ gia đình nghèo nhất vì người được trợ cấp sử dụng khoản thu nhập này để chi trả các nhu cầu cơ bản của gia đình. Chẳng hạn, ở tỉnh Kwa-Zulu Natal ở Nam Phi có trên 60% hộ gia đình có từ ba thế hệ trở lên. Các hộ có người được trợ cấp sống khá hơn những hộ không có. Ở nhiều vùng khác tình hình cũng giống như vậy (xem Khung 6).

Ngoài ra, chi chuyển khoản tiền mặt cho người nhiều tuổi thường kích thích nền kinh tế địa phương. Thực tế ở Braxin, Namibia và Nam Phi cho thấy người nhiều tuổi thường đầu tư vào các hoạt động tạo ra thu nhập (Gorman 2004). Qua kinh nghiệm ở các nước này cũng thấy rằng trợ cấp xã hội (thậm chí dù rất nhỏ) cũng làm tăng khả năng vay tín dụng chính thức của các hộ gia đình vì trợ cấp xã hội là một dạng thu nhập thường xuyên hàng tháng. Khi khả năng vay tín dụng chính thức được cải thiện thì cũng có thể góp phần giảm sự phụ thuộc của người nghèo vào các mạng lưới an sinh (xem Khung 6)

Khung 6: Trợ cấp không yêu cầu đóng góp ở Nam Phi

Chính phủ Nam Phi thực hiện một hệ thống trợ cấp xã hội khá rộng rãi. Chương trình này là một phần nỗ lực của chính phủ để mở rộng các hệ thống trợ cấp hiện có cho tất cả các nhóm dân tộc sau khi kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc. Hệ thống này chi chuyển khoản tiền mặt cho những người trên độ tuổi nhất định cho dù người đó có được hưởng các trợ cấp khác hay không. Số tiền được nhận bằng hai lần mức thu nhập đầu người bình quân của các hộ gia đình người Phi, mà các hộ người Phi chiếm đa phần số nghèo ở Nam Phi. Trong năm 1993, mức trợ cấp tương đương khoảng bằng USD3/ngày đối với tất cả phụ nữ trên 60 và tất cả nam giới trên 65 (Case và Deaton 1998). Hiện nay, trợ cấp xã hội tương đương trên USD110/tháng (Gorman 2004). Nguồn chi trả trợ cấp này chiếm 1,4% GDP của Nam Phi trong năm 2000. Chương trình đã chứng tỏ tái phân phối được thu nhập cho

²⁶ Bộ LĐ-TBXH đã thực hiện các chương trình thí điểm đối với bảo hiểm trợ cấp tự nguyện cho nông dân ở ba tỉnh. Hiện chưa có đánh giá về các chương trình này.

²⁷ Xem thêm thông tin thực tế trong các tài liệu của Ngân hàng Thế giới (1994), Wilmore (2001), Devereaux (2002) và Schwarz (2003).

các hộ nghèo nhất và phạm vi đối tượng người nghèo trong toàn dân (Case và Deaton 1998). Cũng như nhiều nước đang phát triển khác, các hộ gia đình ở Nam Phi thường là các gia đình lớn có nhiều thế hệ. Trợ cấp xã hội đã có tác động tích cực đến phúc lợi trẻ em, vì những người được hưởng trợ cấp hay dùng thu nhập của mình để đầu tư vào học hành và sức khỏe của các cháu mình. Trợ cấp xã hội đặc biệt có vai trò quan trọng ở Nam Phi vì nạn dịch HIV/AIDS tràn lan và đã làm tăng sức ép đối với người nhiều tuổi vì họ phải chăm lo cho các cháu của mình (Gorman 2004). Ở Nam Phi, các em gái sống trong cùng một hộ gia đình với một phụ nữ nhiều tuổi được hưởng trợ cấp cao hơn các em gái sống trong các hộ gia đình khác khoảng 3-4cm (Gorman 2004). Ở Brazil cũng vậy. De Carvalho Filho (2000) thấy rằng trợ cấp xã hội ở Brazil đã làm tăng tỷ lệ đến trường (nhất là đối với các em gái) ở độ tuổi 12-14. Trợ cấp ở Nam Phi cũng là một công cụ hữu hiệu để tăng khả năng tiếp cận với các nguồn tín dụng chính thức và đảm bảo an ninh lương thực vì đó là một nguồn thu nhập đáng tin cậy (Ardington và Lund 1994). Chẳng hạn trong những năm hạn hán ở Namibia, trợ cấp xã hội được sử dụng để mua lương thực cho cả gia đình (Devereaux 2001). Gorman (2004) cho biết ở Nam Phi, trong số các hộ gia đình có từ ba thế hệ trở lên, các hộ có người được hưởng trợ cấp ít khi bị tụt xuống dưới ngưỡng nghèo hơn các hộ khác. Ông ước tính rằng việc chi chuyển khoản cho trợ cấp xã hội đã làm tỷ lệ nghèo ở Nam Phi giảm khoảng 12,5% (Gorman 2004). Tỷ lệ này ở Brazil là 8% (De Carvalho Filho 2000). Hệ thống trợ cấp ở Nam Phi là một ví dụ thành công về 'nguồn phụ thêm' (Akerloff 1978). Trong hệ thống trợ cấp xã hội, việc chi chuyển khoản tiền mặt hướng vào các đối tượng hộ gia đình có những đặc điểm nhất định có liên quan đến nghèo. Trong trường hợp này, đặc điểm có liên quan là tuổi già. Bằng cách giới hạn đối tượng hưởng chuyển khoản vào một nhóm nào đó để xác định, chi phí hành chính sẽ thấp hơn so với các chương trình có chế độ mang tính chất đơn thuần toàn dân (trong các chương trình toàn dân này thì chi chuyển khoản dành cho tất cả mọi người trong toàn dân) hoặc so với các chương trình dựa vào xác minh tiềm lực tài chính (trong các chương trình này chỉ hướng vào đối tượng người nhiều tuổi dưới ngưỡng nghèo).

Trợ cấp xã hội không yêu cầu đóng góp đòi hỏi phải có sự ủng hộ rộng rãi của người dân và chính trị để tạo điều kiện thực hiện thuận lợi. Trợ cấp này có nhiều ưu điểm về mặt hành chính hơn trợ cấp dựa vào xác minh tiềm lực tài chính vì xác định rõ ràng đối tượng được hưởng. Do vậy, hệ thống này minh bạch hơn các hệ thống dựa vào xác minh tiềm lực tài chính và dễ hiểu hơn, cả đối với người xin trợ cấp và người quản lý. Việc xác định đối tượng cũng rất đơn giản vì có thể sử dụng giấy khai sinh, thẻ cử tri hoặc các phương tiện xác minh bình thường khác để xét có đủ điều kiện không. Ngoài ra, khi thực hiện các hệ thống trợ cấp xã hội cũng tận dụng được các thể chế tổ chức hiện có như các trạm bưu điện và chi nhánh ngân hàng ở địa phương. Công tác quản lý hành chính cũng ít tốn kém hơn các hình thức trợ giúp khác. Ở Botswana và Namibia, chi phí hành chính chiếm từ 2-3% tổng trợ cấp chi trả, ít hơn nhiều so với các chương trình trợ cấp dựa vào xác minh tiềm lực tài chính. Chi phí tổng thể tính theo GDP cũng thấp. Chương trình trợ cấp xã hội ở Namibia chiếm chưa đến 2% GDP, và chương trình ở Nam Phi có nguồn tài chính cấp từ nguồn thuế chung trong năm 2000 chiếm 1,4% GDP.

Trợ cấp xã hội dành cho tất cả mọi người, kể cả người lao động trong khu vực không kê khai và các nhóm đối tượng khác thường không được hưởng các trợ cấp thuộc về khu vực chính thức. Trợ cấp này không gắn với đóng góp của chủ sử dụng lao động hoặc người lao động. Vì qui mô tuyệt đối của nguồn trợ cấp này nhỏ và nhiều đối tượng hưởng trợ cấp dù thế nào cũng không gia nhập lực lượng lao động, nên trợ cấp xã hội không ảnh hưởng đến việc khuyến khích lao động.

Một bài học chính rút ra từ các chương trình trợ cấp xã hội hiện nay là trợ cấp nên bắt đầu từ mức thấp và tăng dần lên khi hệ thống thuế phát triển. Chẳng hạn như ở Bolivia, Bonosol chỉ có 75 xu một ngày. Thậm chí ngay với mức trợ cấp này thì chương trình cũng đã có tác động đáng kể đến mức sống của những người rất nghèo. Ngân hàng Thế giới (1994) đã đề xuất mức trợ cấp đều nhau là 20% lương trung bình. Ở một nước có cấu trúc dân số trẻ, thì chỉ cần mức thuế theo bảng lương có 2%. Có một ý kiến là đối với những nước lần đầu tiên thực hiện hệ thống này trước hết cần dành cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất. Chẳng hạn trợ cấp trong giai đoạn đầu có thể giới hạn cho người trên 75 tuổi. Ở Việt Nam cần nghiên cứu thêm để xác định các nhóm đối tượng có nhu cầu nhất và mức trợ cấp phù hợp cho các nhóm này.

Weeks và các tác giả (2004) đã đề xuất nên áp dụng dạng trợ cấp xã hội toàn dân ở Việt Nam. Trợ cấp xã hội không yêu cầu đóng góp do chính phủ trung ương cấp ngân sách sẽ làm cho công tác trợ giúp xã hội ở cấp tỉnh và huyện đỡ chênh lệch nhau hơn so với hiện nay. Xét về mặt hành chính, Việt Nam có thuận lợi là đã có một hệ thống quản lý hành chính có tổ chức tốt xuống tới cấp xã. Các xã chịu trách nhiệm về đăng ký nhân khẩu và do đó có thể xác minh độ tuổi của người xin trợ cấp mà không cần phải giới thiệu sang các cơ quan khác.

4.3. Khả năng tài chính

Việt Nam giống như tất cả các nước đang phát triển khác có nhiều khó khăn về ngân sách. Để bền vững, các chương trình xã hội mở rộng phạm vi tham gia cho người lao động trong khu vực không kê khai, lao động tự do, dân di cư, và các nhóm dễ bị tổn thương khác không được phép tạo thêm gánh nặng quá mức cho nguồn tài chính công. Trong toàn bộ văn kiện này có đề xuất một số biện pháp giúp chính phủ có thể có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu ngân sách xã hội tăng thêm:

- i. Các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân phải tham gia vào các chương trình bảo hiểm cho người lao động chống lại các rủi ro trên thị trường lao động, và sự tham gia này là bắt buộc và phải thực hiện;
- ii. Cần phát triển các thị trường bảo hiểm và vốn để các tổ chức đầu tư như các quỹ trợ cấp có thể có đủ cơ hội đầu tư đảm bảo;
- iii. Các mạng lưới an sinh xã hội nên hướng vào các nhóm đối tượng dễ xác định chứ không phải là người nghèo nói chung;
- iv. Chi chuyển khoản giữa các tỉnh giàu và tỉnh nghèo phải thoả đáng, minh bạch và giám sát tốt (ILO 1999a, UNDP-Bộ LĐ-TBXH 2004);
- v. Cần phải giảm chi phí tổ chức và hành chính;
- vi. Cần phân tích cẩn thận chi phí-lợi ích xã hội của các phương án chính sách để xác lập ưu tiên, xác định mức trợ cấp và đặt chuẩn cho tác động xã hội.

Biện pháp dưới cùng trong danh mục này cần thực hiện phần nào khẩn cấp vì mức chi tiêu công cho các chương trình xã hội đang tăng. Chính phủ cần phải xác định mức hỗ trợ tối ưu cần thiết để đảm bảo cho người dân chống lại các rủi ro về kinh tế-xã hội mà không phụ thuộc nhiều hơn vào sự trợ giúp của chính phủ một cách không thích đáng.

Weeks và các tác giả (2004) đã đánh giá chi phí thực hiện trợ cấp xã hội không yêu cầu đóng góp ở Việt Nam và cho rằng trợ cấp xã hội ở Việt Nam có thể đứng vững về mặt tài chính. Các tác giả đã ước tính chi phí trợ cấp cho mọi người trên 65 (dù có về hưu hay không) cho năm 1998 với mức giá năm 1993 (Bảng 7). Theo giả định trong các tính toán này thì có thể chi trả trợ cấp thông qua các thể chế tổ chức hiện nay mà không mất chi phí hành chính cho hệ thống. Mức trợ cấp trong Bảng 7 dựa theo hai tính toán đơn giản: tỷ lệ giữa ngưỡng nghèo và mức tiêu dùng bình quân đầu người và tỷ lệ giữa mức trợ cấp theo đề xuất với ngưỡng nghèo áp dụng trong ĐTMSVN năm 1998. Khi mức trợ cấp bằng ngưỡng nghèo thì chi phí cho năm 1998 sẽ là 2,2% GDP, như vậy tổng chi tiêu xã hội sẽ tăng một phần ba hoặc tổng vãng lai hiện nay tăng 15%. Tỷ lệ giữa mức trợ cấp so với ngưỡng nghèo thấp hơn thì chi phí cũng thấp hơn. Các tác giả còn chỉ ra rằng khi nền kinh tế tăng trưởng, chi phí cho trợ cấp sẽ giảm xuống. Chẳng hạn, giả định mức chi tiêu cho tiêu dùng trong giai đoạn 1998-2003 tăng 4%, tỷ lệ giữa ngưỡng nghèo so với mức tiêu dùng bình quân sẽ giảm từ 0,64 xuống còn 0,52, và tổng chi khi mức trợ cấp ngang bằng ngưỡng nghèo sẽ chưa đến 2% GDP. Nếu tính toán như vậy thì ngay cả khi mức trợ cấp xã hội bằng ngưỡng nghèo thì cũng vẫn hoàn toàn trong phạm vi khả năng tài chính của chính phủ. Khi chi phí thấp như vậy còn cho thấy các chương trình khác, chẳng hạn như trợ giúp trẻ em (như đã nói trong phần nghiên cứu) và chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn dân, cũng có tính khả thi.

Bảng 7: Chi ngân sách ước tính cho trợ cấp toàn dân (năm 1998 theo mức giá năm 1993)

Mục	Đơn vị	Giá trị
Tỷ lệ phần trăm dân số từ 65 tuổi trở lên	phần trăm	4,9
tiêu dùng tư nhân	tỷ đồng (giá năm 1993)	194841
GDP	tỷ đồng (giá năm 1993)	274811
tiêu dùng tư nhân/GDP	phần trăm	70,9
chi tiêu chính phủ/GDP: các dịch vụ xã hội	phần trăm	6,8
Tổng vãng lai	phần trăm	14,7
Tổng cộng	phần trăm	21,9
tiêu dùng theo đầu người (ĐTMSVN)	đồng, nghìn	2784
Ngưỡng nghèo quốc tế *	đồng, nghìn	1790
Chi phí trợ cấp ước tính:		
trợ cấp/ngưỡng nghèo	tỷ số	1,00 0,90 0,80 0,70
ngưỡng nghèo/mức tiêu dùng trung bình	tỷ số	0,64 0,64 0,64 0,64
mức trợ cấp cho một người	đồng, nghìn (giá năm 1993)	1790 1611 1432 1253
chi trợ cấp/GDP	phần trăm	2,2 2,0 1,8 1,6
[giả định 10% chi phí hành chính]	[phần trăm]	[2,4] [2,2] [2,0] [1,8]

Mức chi tăng: các dịch vụ xã hội	phần trăm	33,0	29,7	26,4	23,1
Tổng vắng lai	phần trăm	15,3	13,8	12,2	10,7
Tổng cộng	phần trăm	10,3	9,2	8,2	7,2

Chú thích và nguồn:

1. Chỉ tiêu tư nhân & GDP: IMF 1999, trang 4 & 6, là tỷ số giữa chi tiêu tư nhân và GDP giả định không chịu tác động của giảm phát và năm 1993 tính là năm gốc thay cho năm 1994.

2. Ngưỡng nghèo: dùng trong ĐTMSVN 1998.

3. Chỉ tiêu của Chính phủ: từ chương 4, Bảng IV.1.

4. Thống kê dân số: *Chỉ số Phát triển Thế giới 2001*.

5. Ba hàng dưới cùng giả định không có chi phí hành chính.

* Nếu sử dụng ngưỡng nghèo lương thực của Bộ LĐ-TBXH thì kết quả tính trợ cấp và chi phí sẽ giảm khoảng 28% (tức là ngưỡng nghèo lương thực năm 1998 là 0,719 ngưỡng nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế).

4.4. Năng lực thể chế

Cơ cấu quản lý hành chính chính quyền Việt Nam có bốn cấp: chính phủ trung ương, 64 tỉnh thành, và 582 quận huyện. Cơ cấu chính quyền xuống đến cấp huyện. Ngoài ra, có trên 10 nghìn xã phường, 90% trong số này ở các vùng nông thôn. Trong một xã có nhiều thôn và các vùng lân cận. Một phường là một đơn vị trong thành phố. Quản lý chính quyền cấp xã phường chịu trách nhiệm thực hiện nhiều chương trình khác nhau của chính phủ đến các hộ gia đình và người dân.

Xét về cách tổ chức bảo hiểm xã hội hiện nay, Bộ LĐ-TBXH chịu trách nhiệm phối hợp các chương trình trợ giúp xã hội và bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo điều phối các chương trình y tế và giáo dục (kể cả các chương trình thuộc CTMTQG). Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý tất cả các chương trình bảo hiểm xã hội trong khu vực chính thức.

Hiện nay có rất nhiều chồng chéo giữa các chính sách được quản lý trong các chương trình bảo hiểm xã hội và y tế và các chính sách XĐGN. Công tác quản lý mạng lưới an sinh trong CTMTQG thực hiện song song cùng với việc thực hiện các quỹ cứu trợ khác nhau như đã mô tả trong Mục 2 ở trên. Việc đầu tiên cần khẩn trương thực hiện để tiến tới phát triển một khuôn khổ toàn quốc hợp nhất là đánh giá cách thức tổ chức quản lý hành chính hiện nay. Khuôn khổ hợp nhất này có các ưu điểm là:

- i. Giảm chi phí hành chính và chồng chéo;
- ii. Tăng cường phổ biến thông tin đến các đối tượng hưởng lợi;
- iii. Cải thiện thiết kế chương trình và khả năng phản ứng khi có thay đổi;
- iv. Ưu tiên rõ ràng hơn cho chính sách công.

Trong cơ cấu hành chính hiện nay cần phải giải quyết một số vấn đề, trong đó có năng lực giám sát, năng lực hành chính và hiệu quả và phạm vi bao phủ của các kênh thông tin.

4.4.1. Năng lực giám sát

Ở Việt Nam tỷ lệ trốn đóng thuế và bảo hiểm xã hội cao, dù các số liệu ước tính về tình trạng này khác nhau. Các hình thức trốn phổ biến là không đăng ký, khai giảm số lao động tuyển dụng và mức thu nhập của họ. Giám sát cũng là một trong những điểm yếu chính trong CTMTQG. Năng lực của chính phủ để mở rộng phạm vi các chương trình bảo hiểm xã hội tùy thuộc vào mức độ tăng cường năng lực giám sát để tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo dựng lòng tin của người dân vào chính các chương trình này. Đặc biệt cần chú ý đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ hành chính, thiết lập các hệ thống kế toán, kiểm toán và giám sát chương trình phù hợp và các hệ thống phân bổ quỹ trung ương cho các tỉnh thành minh bạch và gọn nhẹ.

4.4.2. Năng lực và hiệu quả hành chính

Một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất cần có các kênh trao đổi thông tin và phối hợp tốt hơn giữa ba bộ có liên quan để tránh trùng lặp. Ngoài ra, cần nỗ lực cải thiện công tác phối hợp giữa các bộ chủ quản và Bộ Tài chính. Tăng cường hiệu quả hành chính và năng lực quản lý ở cấp địa phương cũng là những việc cần phải làm (xem Khung 1). Một vấn đề quan trọng khác nữa là kích cầu đối với các dịch vụ bảo hiểm xã hội. Cầu tăng thường làm tăng hiệu quả như trong trường hợp của Kerala (Khung 3). Chẳng hạn, khi tăng cường vai trò của công đoàn trong cả khu vực chính thức và không kê khai sẽ giúp thu hút các đối tượng hưởng lợi tham gia vào quá trình xây dựng chương trình (Khung 3). Người dân tham gia tích cực là chìa khóa đảm bảo trách nhiệm giải trình và sự minh bạch,

và đến lượt các yếu tố này lại cải thiện quá trình thực hiện và góp phần tạo dựng lòng tin của người dân và hỗ trợ cho các chính sách và chương trình bảo hiểm xã hội.

4.4.3. Cải thiện các kênh thông tin

Chính phủ cần phải hành động để cải thiện chất lượng tham gia của tất cả các nhóm trong quá trình lập và thực hiện hệ thống bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, cần có các hệ thống thông tin tốt hơn để các bên có liên quan biết đến các chương trình hiện có và quyền lợi của họ. Phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến được với các cơ quan tổ chức có liên quan. Có nhiều nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất không tiếp cận được các chương trình trợ giúp xã hội đơn giản chỉ vì họ sống xa các trung tâm đô thị, vì họ không biết có các chương trình đó, hoặc vì họ không biết cách xin trợ cấp. Theo Ngân hàng Thế giới (2002), nhiều hộ gia đình Việt Nam hiện hưởng trợ cấp song lại không biết tại sao họ được trợ cấp hoặc không biết họ có nhận được đúng trợ cấp hay không. Cũng có nhiều hộ gia đình nhỡ ra được trợ cấp lại hình như không biết họ có đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Tình trạng không biết đặc biệt phổ biến ở các dân tộc thiểu số do rào cản ngôn ngữ. Việc cung cấp thông tin bằng tiếng dân tộc sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Những thông tin thích hợp có thể dễ dàng dán trên tường ở các trung tâm xã hoặc truyền qua đài phát thanh hoặc truyền hình bằng tiếng địa phương (Ngân hàng Thế giới 2002).

4.5. Vấn đề thời gian

Bây giờ là thời điểm đúng lúc cho Việt Nam bắt đầu quá trình thiết kế một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất. Chính phủ nên tận dụng các điều kiện kinh tế thuận lợi hiện nay để đưa ra các chiến lược tài chính và thể chế cho trung hạn. Đồng thời, Việt Nam có lợi thế là có các hình thức tổ chức không chính thức tương đối hiệu quả có thể giúp giải quyết các nhu cầu xã hội trước mắt. Những ưu thế này chưa đủ để đối phó các rủi ro kinh tế và xã hội trong tương lai song giảm nhẹ được áp lực đối với chính phủ và giúp các nhà hoạch định chính sách có đủ thời gian để lập kế hoạch cho tương lai.

Ngay từ bây giờ cần mở rộng và hoạch định lại các chính sách xã hội hiện nay để hình thành một hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất để đảm bảo khi cần sẽ có. Nếu chần chừ mãi về sau mới quyết định có thể làm cho nhiều người dân phải chịu các rủi ro kinh tế gắn liền với quá trình đô thị hoá, hội nhập kinh tế và dân số già đi. Ngoài ra, nếu trì hoãn trên thực tế còn có thể làm cho khó phát triển một hệ thống hợp nhất hơn vì các chủ sử dụng lao động sẽ đến lúc quan niệm rằng không đóng bảo hiểm xã hội cũng là một quyền kinh tế và người dân trở nên quen chi tiền túi cho y tế, giáo dục và hỗ trợ cho các thành viên cao tuổi trong gia đình.

5. Kết luận và kiến nghị

Văn kiện này trình bày một số vấn đề chính có liên quan đến việc phát triển một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất ở Việt Nam. Chúng ta thấy rằng có một số hợp phần hiện có trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xóa đói Giảm nghèo có thể trở thành cơ sở cho một hệ thống hợp nhất trên toàn quốc. Song kết quả này không có gì đảm bảo cả. Cần phải khắc phục các trở ngại chủ yếu về mặt kinh tế, thể chế và tài chính trước khi chính phủ có thể phát triển một hệ thống có tính toàn diện và phối hợp hơn.

Tuy nhiên, như đã trình bày trong tài liệu này, lợi ích do hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất mang lại có thể cao hơn hẳn so với chi phí. Hệ thống hợp nhất sẽ có thể có hiệu quả hơn, giảm chồng chéo và các chi phí không cần thiết. Hệ thống này hỗ trợ cho sự gắn kết xã hội và ổn định chính trị trong giai đoạn thay đổi nhanh chóng về mặt kinh tế. Hệ thống này cũng bảo vệ cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội khỏi bị di chuyển về mặt kinh tế và không bị mất mát quá nhiều, và qua đó củng cố các chương trình chống nghèo trên toàn quốc. Hệ thống này cũng duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững bằng cách mở rộng các thị trường trong nước và tái phân phối thu nhập cho người tiêu dùng có nhiều khả năng mua hàng sản xuất trong nước hơn so với hàng nhập khẩu.

Hiện nay Việt Nam chưa ở thế sẵn sàng áp dụng ngay lập tức một hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện như ở các nước công nghiệp. Do tầm quan trọng tương đối của lao động tự do và khu vực không kê khai nên các phương pháp này không thích hợp trong hoàn cảnh của Việt Nam. Bên cạnh đó, các thị trường vốn còn sơ khai và thu nhập bình quân còn thấp.

Tuy nhiên, theo như trình bày trong văn kiện này, các chính sách và chương trình khác nhau được áp dụng ở các nước đang phát triển khác đã tạo nên một biện pháp bảo hiểm kinh tế cho những người dễ bị tổn thương. Có một số chính sách và chương trình này khả thi về mặt hành chính và tài chính ở Việt Nam. Khi kết hợp với các phần hiện có trong CTMTQG và các chương trình khác, các phương án chính sách và chương trình này có thể tạo thành cơ sở cho một hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất trong trung hạn. Thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam là phải xác lập được các ưu tiên rõ ràng cho hệ thống bảo hiểm xã hội để đảm bảo sử dụng tốt nhất các nguồn lực khan hiếm.

Những ưu tiên này phải dựa trên nghiên cứu chính sách cẩn thận. Trong văn kiện này có nêu ra một số vấn đề cần xem xét kỹ hơn và có hệ thống hơn, trong đó có các vấn đề sau:

- i. Xác định các rủi ro kinh tế đang nảy sinh và tác động của những rủi ro đó đối với các nhóm dễ bị tổn thương;
- ii. Mối quan hệ giữa bệnh tật, tuổi già, mất sức lao động, và nghèo;
- iii. Phân tích các điều kiện ở khu vực không kê khai, trong đó có phân bố theo ngành, tầm quan trọng tương đối của lao động làm công ăn lương tạm thời và thường xuyên, qui mô và năng suất doanh nghiệp;
- iv. Phân tích chi phí-lợi ích xã hội của các phương án chính sách và chương trình, trong đó có phân tích tác động đối với nghèo, phân phối thu nhập, biến đổi thu nhập, sự gắn kết xã hội và ổn định chính trị;
- v. Phân tích kinh tế chính trị của thuế, trong đó có tình trạng thuế, phân phối, thực thi, và tác động của việc gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp ước thương mại khác.

Trong số này có một số nghiên cứu có thể tiến hành trên cơ sở thực tế kinh nghiệm hiện có. Tuy nhiên, rất cần tiến hành các cuộc điều tra được thiết kế riêng để nghiên cứu các rủi ro kinh tế và khả năng tổn thương, trong đó có thu thập dữ liệu về di dân từ nông thôn ra thành thị và giữa các vùng nông thôn, phân phối thu nhập và các nguồn lực khác trong hộ gia đình và những hạn chế cản trở sự tham gia vào thị trường lao động.

Khi đã xác định được các ưu tiên chương trình, thì cần phải tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các bộ chủ quản, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu trách ở địa phương để nâng cao hiệu quả và tính gián công tác hành chính. Trách nhiệm giải trình và sự minh bạch cũng là những yếu tố căn bản để tăng cường các hệ thống giám sát và làm cho người dân ủng hộ các chính sách và chương trình bảo hiểm xã hội. Thực hiện có hiệu quả đóng vai trò thiết yếu nhằm đảm bảo khả năng tài chính của các chương trình bảo hiểm xã hội và nguồn lực hạn chế đến được với các đối tượng hưởng lợi như dự kiến.

Trong văn kiện này có trình bày rằng cần phải nghiên cứu và lập kế hoạch ngay từ bây giờ để đảm bảo đã có sẵn một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất khi nhiều người dân Việt Nam phải đối mặt các rủi ro kinh tế mới có thể xảy ra trong quá trình công nghiệp hoá và trong quá trình phát triển. Nếu bắt đầu sớm còn có thể góp phần gây dựng ý thức rằng trách nhiệm đối với bảo hiểm xã hội phải được chia xẻ giữa người lao động, chủ sử dụng lao động và chính phủ. Việc khởi xướng đối thoại tầm quốc gia với sự tham gia của chính phủ, các tổ chức quần chúng, người dân, chủ sử dụng lao động, các nhà tài trợ, các nhà nghiên cứu, và các bên đối tác phát triển khác có vai trò quan trọng căn bản để đạt được sự nhất trí trên toàn quốc về tương lai của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

PHỤ LỤC: Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Quốc gia hợp nhất ở Việt Nam

Các thành phần trong hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất	Các thành phần hiện có	Các thành phần bổ sung	Yêu cầu
1. Bảo hiểm xã hội cho người lao động trong khu vực chính thức (tư nhân và nhà nước)	- Trợ cấp hưu trí - Tai nạn nghề nghiệp - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp thai sản (cho đến hai con)	- Trợ cấp thất nghiệp - Trợ cấp mất sức lao động - Mở rộng trợ cấp thai sản	- Giảm đóng góp của chính phủ - Tăng cường hệ thống giám sát - Thực thi chi trả đóng góp của chủ sử dụng lao động - Yêu cầu các công ty nhà nước và tư nhân (Việt Nam và nước ngoài) tham gia nhiều hơn.
2. Bảo hiểm xã hội cho người lao động trong khu vực không kê khai và và lao động tự do (trong đó có người ngoại tỉnh ở các khu vực thành thị và các dân tộc thiểu số)	Miễn giảm phí khám chữa bệnh theo CTMTQG (cho các đối tượng dưới ngưỡng nghèo)	Các yêu cầu trước mắt: - Bảo hiểm y tế - Hệ thống trợ cấp (kết hợp cả tư nhân/nhà nước như ở Trung Quốc, trợ cấp không yêu cầu đóng góp như ở Nam Phi hoặc trợ cấp theo nhóm nghề như ở Nam Ấn Độ) Các yêu cầu trung hạn: - Tai nạn nghề nghiệp - Trợ cấp thai sản - Trợ cấp mất sức lao động - Trợ cấp trẻ em Yêu cầu dài hạn: - Trợ cấp thất nghiệp	- Giảm số cơ quan hành chính - Giảm/Xoá bỏ hệ thống hộ khẩu (residential permit); xem xét áp dụng hệ thống sổ bảo hiểm xã hội trên toàn quốc - Xoá bỏ tình trạng quá dựa vào công tác xác minh tiềm lực tài chính - Xây lập các kênh truyền thông tốt hơn giữa các bộ, giữa các bộ và cơ quan chính quyền địa phương, và giữa các bộ và cơ quan chính quyền địa phương và các nhà tài trợ - Tăng cường thông tin đến cho người xin trợ cấp (kể cả dịch các tài liệu quan trọng sang tiếng dân tộc) - Hợp nhất dần chương trình này với các chính sách của khu vực chính thức
3. Trợ giúp xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể (trong đó có dân tộc thiểu số, người tàn tật, người già cô đơn, người mẹ độc thân, và trẻ mồ côi)	- Trợ cấp theo CTMTQG cho những người dưới ngưỡng nghèo (trong đó có trợ giúp đặc biệt cho người dễ bị tổn thương và dân tộc thiểu số) - Quỹ cứu đói giáp hạt - Quĩ hỗ trợ xã hội dành cứu trợ thường xuyên	- Các chương trình an ninh lương thực (bữa ăn cơ bản cho trẻ em ở trường học và phụ nữ có thai dễ bị tổn thương) - Hỗ trợ chăm sóc tại cộng đồng và gia đình	- Tinh giản tổ chức thể chế - Chuyển khoản nguồn lực từ các tỉnh giàu sang các tỉnh nghèo - Giảm phạm vi đối tượng từ toàn bộ người nghèo thành tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể - Cải thiện thông tin cho người xin trợ cấp - Củng cố các mạng lưới cộng đồng

và gia đình

4. Trợ giúp xã hội cho các nhóm đặc biệt

4.1. Cựu chiến binh

4.2. Gia đình liệt sĩ

- Quỹ bảo hiểm xã hội cho cựu chiến binh và thương binh (trợ cấp hưu trí và tiền tuất)

- Trợ cấp giảm dần vì số đối tượng này trong dân số giảm dần

5. Cứu trợ xã hội

- Quỹ dự phòng cứu trợ thiên tai

- Tách khỏi quỹ cứu đói giáp hạt

- Chi trả theo sự cố xảy ra
- Không sử dụng quỹ cho các mục đích khác

Tài liệu tham khảo

- Aaron, H. J. (1982) *Tác động kinh tế của bảo hiểm xã hội*. Brookings Institution, Washington, D.C.
- Agarwal, B. (1991) “Bảo hiểm xã hội và gia đình: Đối phó với tính mùa vụ và thiên tai ở nông thôn Ấn Độ”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.
- Ahmad, E. (1991) “Bảo hiểm xã hội và người nghèo: các phương án lựa chọn đối với các nước đang phát triển”. *Người Quan sát Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới* 6 (1): 105-127.
- Ahmad, E. và Hussain, A. (1991) “Bảo hiểm xã hội ở Trung Quốc: cách nhìn theo quan điểm lịch sử”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (biên soạn.), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.
- Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (1991) *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.
- Akerlof, G. (1978) “Tính kinh tế của ‘nguồn phụ thêm’ khi áp dụng với thuế thu nhập tối ưu, các chương trình phúc lợi và lập kế hoạch nhân lực”, *Tạp chí Kinh tế Mỹ* 68 (1): 8-19.
- Alesina, A. và Perotti, R. (1993) *Phân phối thu nhập, Mất ổn định chính trị và Đầu tư*, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, Văn kiện Làm việc số 4486.
- Ardington, L. và Lund, F. (1994) *Trợ cấp và phát triển: Hệ thống bảo hiểm xã hội là con đường bổ sung cho các chương trình tái thiết và phát triển*. Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Phát triển, Trường Đại học Tổng hợp Natal, Durban.
- Arenas de Mesa, A. và Bertranou, F. (1997) “Bài học từ các cuộc cải cách bảo hiểm xã hội: hai trường hợp khác nhau, Chilê và Argentina”. *Phát triển Thế giới* 25 (3): 329-348.
- Atkinson, A. B. (1989) *Nghèo và bảo hiểm xã hội*. Harvester Wheatsheaf, Hempstead.
- Atkinson, A. B. và Stiglitz, J. (1980) *Các bài thuyết trình về kinh tế công cộng*. McGraw-Hill, London.
- Atkinson, A. B. và Hills, J. (1991) “Bảo hiểm xã hội ở các nước phát triển: có bài học nào dành cho các nước đang phát triển?”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.
- Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004: Nghèo. Báo cáo chung của các nhà tài trợ trình bày tại Hội nghị các Nhà Tài trợ Việt Nam, Hà Nội, 2-3 tháng 12 năm 2003.
- Barrientos, A. và Shepard, A. (2003) *Nghèo kinh niên và bảo trợ xã hội*. Tài liệu trình bày tại Hội nghị CPRC về Nghèo Kinh niên, Trường Đại học Tổng hợp Manchester, tháng 4.
- Becker, W. Büchner, H. và Sleeking, S. (1987) “Tác động của chi chuyển khoản công đối với trốn thuế: một phương pháp tiếp cận thử nghiệm”. *Tạp chí Kinh tế Công Cộng* 34 (2): 243-252.
- Besley, T. và Kanbur, R. (1993) “Các nguyên tắc chọn đối tượng” trong Lipton, M. và Van der Gaag, J. (biên soạn) *Tính cả người nghèo*. Ngân hàng Thế giới, Chương 3.
- Bộ LĐ-TBXH-UNDP (2004) *Dự trữ và lập kế hoạch cho tương lai: Đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo (CTMTQG về XDGN) và chương trình 135*. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Hà Nội.
- Bộ Y tế (2000) *Niên giám thống kê*. Bộ Y tế, Hà Nội.

Bộ Y tế (2004) *Đánh giá tình hình thực hiện Năm 1 công tác khám và điều trị người nghèo (Theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)* Bộ Y tế, Hà Nội.

Burgess, R. và Stern, N. (1991) “Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển: Cái gì, tại sao, ai, và như thế nào?”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.

Case, A. (2001) *Liệu tiền có bảo vệ được sức khỏe? Dẫn chứng về trợ cấp ở Nam Phi*. Văn kiện làm việc NBER 8495. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, Cambridge, MA.

Case, A. và Deaton, A. (1998) “Chi chuyển khoản tiền mặt lớn cho người nhiều tuổi ở Nam Phi”. *Tạp chí Kinh tế* 108 (450)

Case, A. và Wilson, F. (2000) *Y tế và Sức khỏe ở Nam Phi: Dẫn chứng từ điều tra Langberg*. Mimeo, Trường Đại học Princeton.

Chenery, H., Ahluwalia, M. S., Bell, C. L. G., Duloy, J. H. và Jolly, R. (1974) *Tái phân phối với tăng trưởng: các chính sách cải thiện phân phối thu nhập ở các nước đang phát triển trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế*. Nhà Xuất bản trường Đại học Tổng hợp Oxford, London.

Chính quyền Kerala (1997) *Báo cáo của tổ công tác về bảo hiểm xã hội và phúc lợi*. Ban Kế hoạch Nhà nước, Thiruvanthapuram.

Conway, T. (1999) *Các vấn đề hiện nay trong các phương pháp áp dụng theo ngành đối với phát triển y tế: Nghiên cứu tình hình ở Việt Nam*. Viện Phát triển Hải ngoại & Tổ chức Y tế Thế giới.

Conway, T., de Haan, A. và Norton, A. (2000) *Bảo trợ xã hội: phương hướng mới đối với các tổ chức tài trợ*. Ban Phát triển Xã hội, Viện Phát triển Hải ngoại.

Cox, D. (2002) *Chi chuyển khoản tư nhân giữa các hộ gia đình ở Việt Nam đầu và cuối thập kỷ 1990*. Mimeo, Ban Kinh tế học, Trường Đại học Boston.

Dasgupta, P. (1993) *Một điều tra về sức khỏe và nghèo túng*. Nhà xuất bản trường Đại học Tổng hợp Oxford, Oxford.

De Carvalho Filho, I. (2000) *Thu nhập hộ gia đình là một yếu tố quyết định lao động trẻ em và tình hình đến trường ở Braxin: dẫn chứng về một cuộc cải cách bảo hiểm xã hội*. Mimeo, MIT.

Dev, S. M. (1996) “Bảo hiểm xã hội đối với người lao động Ấn Độ: tình hình thực hiện và các vấn đề”. *Tạp chí Kinh tế Lao động Ấn Độ* 39 (4): 883-914.

Devereaux, S. (2001) *Trợ cấp xã hội ở Namibia và Nam Phi*. Văn kiện Thảo luận IDS 379. Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Tổng hợp Sussex, Brighton, Vương Quốc Anh.

Devereaux, S. (2002) “Liệu các mạng lưới an sinh xã hội có thể giảm nghèo kinh niên?”, *Tạp chí Chính sách Phát triển* 20 (5)

DfID-UNDP (2003) *Giảm nghèo ở vùng núi phía Bắc: Tổng hợp các đánh giá nghèo có sự tham gia của người dân ở tỉnh Lào Cai và Hà Giang và số liệu ĐTMSHGĐVN khu vực*. DfID và UNDP, Hà Nội.

Drèze, J. và Sen, A. K. (1991) “Hành động công về bảo hiểm xã hội: nền tảng và chiến lược”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.

Feldstein, M. (1974) “Bảo hiểm xã hội, khuyến khích hưu trí và tổng tích lũy”. *Tạp chí Kinh tế Chính trị* 82 (5): 18-23.

Ghatak, M. và Ghatak, M. (2002) *Những cải cách gần đây trong Hệ thống Panchayat ở Tây Bengal: Tiến tới một chính phủ có sự tham gia nhiều hơn của người dân?* Tuần báo Kinh tế và Chính trị, số ngày 5 tháng 1: 45-58.

Gorman, M. (2004) *Tuổi già và bảo hiểm*. HelpAge International, London.

Guhan, S. (1992) “Các sáng kiến bảo hiểm xã hội ở Tamilnadu năm 1989”. Trong Subramanian (biên soạn), *Các chủ đề về phát triển*. Nhà Xuất bản trường Đại học Tổng hợp Oxford, Oxford.

Guhan, S. (1994) “Các phương án lựa chọn bảo hiểm xã hội đối với các nước đang phát triển”. *Tạp chí Lao động Quốc tế* 133 (1): 35-54.

Harriss, J. (2001) *Xây dựng vốn xã hội và củng cố xã hội dân sự ở các vùng nông thôn*. Văn kiện Làm việc DESTIN 00-16, Trường Đại học Kinh tế London, London.

Haughton, D., Haughton, J. và Nguyễn, P. (2001) *Mức sống trong thời kỳ bùng nổ kinh tế: trường hợp ở Việt Nam*. UNDP và Tổng cục Thống kê, Hà Nội.

Heller, P. (1996) “Vốn xã hội là một sản phẩm của sự huy động tầng lớp và sự can thiệp của nhà nước: người lao động công nghiệp ở Kerala, Ấn Độ”. *Phát triển Thế giới* 24 (6): 1055-1071.

ILO (1984) *Bước vào Thế kỷ 21: Phát triển bảo hiểm xã hội*. Geneva: Tổ chức Lao động Quốc tế.

ILO (1999a) *Các mạng lưới an sinh xã hội ở Việt Nam*. Văn phòng Lao động Quốc tế, Geneva.

ILO (1999b) *Mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội*. Tài liệu trình bày tại Hội thảo Quốc gia về Phát triển Bảo trợ Bảo hiểm Xã hội ở Việt Nam. Hà Nội, 30 tháng 9 – 1 tháng 10 năm 1999.

Justino, P. và Litchfield, J. (2003) *Tính năng động của nghèo ở các vùng nông thôn Việt Nam: Người được và người mất trong cải cách*. Văn kiện Làm việc PRUS số no. 10, Ban Nghiên cứu về Nghèo, Trường Đại học Tổng hợp Sussex.

Kabeer, N. (2002) *Các mạng lưới an sinh và bậc thang cơ hội: Giải quyết khả năng tổn thương và tăng năng suất ở Đông Á*. Văn kiện Làm việc ODI 159. Viện Phát triển Hải ngoại, Luân Đôn.

Krishnamurty, J. (1999) *Mạng lưới an sinh xã hội cho các nhóm dễ tổn thương ở Việt Nam*. Báo cáo về việc làm và các hệ thống an sinh xã hội thị trường lao động cho các nhóm dễ tổn thương ở Việt Nam. Chi nhánh Chính sách Việc làm và Chính sách Thị trường Lao động, Ban Việc làm và Đào tạo, Văn phòng Lao động Quốc tế, Geneva.

Lempert, D., Nguyễn Văn Lê, và Bách Tấn Sinh (2004) *Đánh giá năng lực thể chế trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam (NDM-Đối tác, Giai đoạn 1 Báo cáo Chính)*. UNDP, Hà Nội.

Liên Hợp Quốc (1999) *Các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam. Phân tích chi tiêu của nhà nước và các nhà tài trợ*. Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ LĐ-TBXH, Hà Nội

Mesa-Lago, C. (1983) “Bảo hiểm xã hội và nghèo cùng cực ở châu Mỹ Latinh”. *Tạp chí Kinh tế Phát triển* 12: 83-110.

Mesa-Lago, C. (1991) “Bảo hiểm xã hội ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribê: Đánh giá so sánh”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.

Midgley, J. (1984) *Bảo hiểm xã hội, bất bình đẳng, và thế giới thứ ba*. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.

Minford, M., Quang, D., Nguyễn, H. T. và Brooke, P. (2004) *Nghiên cứu theo dõi chỉ tiêu Chương trình Xoá đói Giảm nghèo và Chương trình 135: Báo cáo chính thức*. Văn bản cơ sở của Bộ LĐ-TBXH-UNDP (2004), cùng tác giả.

- Mouton, P. (1975) *Bảo hiểm xã hội ở châu Phi: Xu hướng, vấn đề và triển vọng*. Tổ chức Lao động Quốc tế, Geneva.
- Murphy, K. M., Shleifer, A. và Vishny, R. (1989) “Phân phối thu nhập, qui mô thị trường và công nghiệp hoá”. *Tạp chí Kinh tế quý CIV* (3): 537-564.
- Myles, G. (1995) *Kinh tế công cộng*. Nhà Xuất bản trường Đại học Cambridge, Cambridge.
- Neefjes, K. (2002) *Các bài học từ lũ lụt: tiếng nói của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Mêkông ở Việt Nam*. IFRC, VNRC và AusAid, Hà Nội.
- Neefjes, K. (2004) *Sự tham gia và trao quyền trong chương trình xoá đói giảm nghèo: báo cáo về nghiên cứu tại bàn*. Báo cáo về Dự án VIE/02/001 Hỗ trợ Cải tiến và Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về XĐGN. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Hà Nội
- Newbery, D. và Stern, N. (1987) (biên soạn) *Lý thuyết hệ thống thuế ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản trường Đại học Tổng hợp Oxford, Oxford.
- Ngân hàng Thế giới (1994) *Ngăn ngừa khủng hoảng tuổi già: các chính sách bảo trợ người nghèo và thúc đẩy tăng trưởng*. Nhà Xuất bản trường Đại học Oxford, Washington D. C.
- Ngân hàng Thế giới (1999) *Báo cáo Phát triển Việt Nam 2000: Tấn công nghèo*, Hà Nội.
- Ngân hàng Thế giới (2002) *Địa phương hoá các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với giảm nghèo ở Việt Nam: Giảm khả năng dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội*. Tổ công tác về nghèo, Ngân hàng Thế giới, Hà Nội.
- Norton, A., Conway, T. và Foster, M. (2001) *Khái niệm và phương pháp bảo trợ xã hội: Ý nghĩa chính sách và thực hiện trong phát triển quốc tế*. Trung tâm Viện trợ và Chi tiêu Công Văn kiện Làm việc 143, Viện Phát triển Hải ngoại, London.
- Osmani, S. (1991) “Bảo hiểm xã hội ở Đông Á”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.
- Perotti, R. (1993) “Cân bằng chính trị, phân phối thu nhập và tăng trưởng”. *Đánh giá Nghiên cứu Kinh tế* 60 (4): 755-776.
- Platteau, J. (1991) “Các hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm cứu đói truyền thống: thành tựu trước đây và thách thức thời hiện đại”. Trong Ahmad, E., Drèze, J., Hills, J., Sen, A. K. (biên soạn), *Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển*. Nhà Xuất bản Clarendon, Oxford.
- Prescott, Nicholas (1997) *Nghèo, các dịch vụ xã hội, và mạng lưới an sinh ở Việt Nam*. Văn kiện Thảo luận của Ngân hàng Thế giới số 376. Ngân hàng Thế giới, Washington D. C.
- Rajan, S. (2004) *Chương trình trợ cấp tuổi già Nepal*. Tài liệu trình bày tại hội thảo về trợ giúp xã hội cho người nhiều tuổi, New Delhi, Ngân hàng Thế giới, tháng 1.
- Saint-Paul, G. và Verdier, T. (1992) *Giáo dục, dân chủ và tăng trưởng*, Trung tâm Nghiên cứu Thực hiện Kinh tế, Văn kiện Thảo luận số 613.
- Schmidt, S. (1995) “Bảo hiểm xã hội ở các nước đang phát triển: các nguyên lý cơ bản và lĩnh vực can thiệp của nhà nước”. *Công trình Xã hội Quốc tế* 38: 7-26.
- Schwarz, A. (2003) *Bảo hiểm tuổi già và trợ cấp xã hội*. Ngân hàng Thế giới, Washington D. C.
- Sepehri, Ardeshir (2005) ‘Phí người sử dụng, tự chủ tài chính và tiếp cận các dịch vụ xã hội ở Việt Nam’, Văn kiện Thảo luận Liên Hợp Quốc, Hà Nội, tháng 3.

Singh, V., Gehlot, B., Start, D. và Johnson, C. (2003) *Ngoài tầm: Chính trị địa phương và phân phối quỹ phát triển ở Madhya Pradesh*. Viện Phát triển Hải ngoại, Văn kiện Làm việc 200, London.

Sinha, S. và Lipton, M. (1999) *Biến động không mong muốn, rủi ro và nghèo: Đánh giá*. Văn kiện cơ sở cho Báo cáo Phát triển Thế giới 2000/01. Ngân hàng Thế giới, Washington D. C.

Soneja, S. (2003) *Trợ cấp không yêu cầu đóng góp ở Ấn Độ: Trường hợp ở Uttar Pradesh*. HelpAge India, HelpAge International.

Takayama, N. (1992) *Người nhiều tuổi ở Nhật Bản: Một quan điểm kinh tế về trợ cấp công*. Nhà Xuất bản trường Đại học Tổng hợp Oxford, Oxford.

Thompson, K. (1999) *Báo cáo về hệ thống bảo trợ xã hội và an sinh xã hội*. Tổ chức Lao động Quốc tế, Văn phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Trần Quang Thạch (1999) *Cơ sở thực tiễn thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động thủ công*. Văn kiện chuẩn bị cho Hội thảo Quốc gia về Phát triển Bảo trợ Bảo hiểm Xã hội ở Việt Nam, Hà Nội, 30 tháng 9 – 1 tháng 10, 1999.

UNDP (2004) *Dự trữ và lập kế hoạch cho tương lai: Đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và chương trình 135*, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hà Nội

UNICEF và Bộ Y tế (2005) 'Tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em dưới 6 tuổi miền phí', Hà Nội, mimeo.

Van de Walle, D. (2003) *Kiểm tra mạng lưới an sinh công của Việt Nam*. Văn kiện về Bảo trợ xã hội số. 0319, Ban Bảo trợ Xã hội, Hệ thống Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới.

Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (2000) *Nền Kinh tế Việt Nam năm 1999*. Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Weeks, John, Nguyễn Thăng, Rathin Roy và Joseph Lim (2004) *Việt Nam: Tìm kiếm sự bình đẳng trong tăng trưởng*. New York: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Chương trình Khu vực châu Á – Thái Bình Dương về Kinh tế học Vĩ mô Giảm nghèo, tháng 4, 2004.

Wilmore, L. (2001) *Trợ cấp toàn dân ở các nước thu nhập thấp*. Sáng kiến Đối thoại Chính sách, Văn kiện Thảo luận IPD-01-05.

UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của LHQ, tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở 166 quốc gia, giúp họ nghiên cứu và đưa ra giải pháp riêng của mỗi nước cho các thách thức phát triển quốc gia và toàn cầu. Khi những nước này tăng cường năng lực quốc gia, họ dựa vào sự giúp đỡ của các nhân viên UNDP và rất nhiều đối tác của chúng tôi.



Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội - Việt Nam

Tel.: (84 4) 942 1495

Fax: (84 4) 942 2267

e-mail: registry.vn@undp.org

www.undp.org.vn